CONCIERTO ENTRE EL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

SANTANDER, AGOSTO DE 2008

ÍNDICE

Preámbulo

Cláusulas

1. Objeto del Concierto
2. Régimen Jurídico
3. Modelo de Atención Farmacéutica
4. Condiciones de la dispensación
5. Condiciones económicas
6. Sistema de información
7. Procedimiento de facturación
8. Procedimiento de pago
9. Seguimiento y cumplimiento
10. Vigencia del Concierto

Cláusula adicional
Cláusula transitoria
Cláusula final

Anexo A. Condiciones de la dispensación

1. Características generales
2. Recetas facturables
3. Controles especiales. Visado de Inspección
4. Validez de las recetas

Anexo B. Fórmulas Magistrales, Vacunas antialérgicas individualizadas y Visados sin cupón precinto

FÓRMULAS MAGISTRALES

1. Características generales
2. Fórmulas magistrales incluidas en la prestación farmacéutica
3. Fórmulas magistrales excluidas de la prestación farmacéutica
4. Elaboración y dispensación
5. Valoración de las fórmulas magistrales
6. Aportación de las fórmulas magistrales
7. Facturación de las fórmulas magistrales
8. Listado de principios activos
9. Normas de valoración

VACUNAS ANTIALÉRGICAS INDIVIDUALIZADAS
VISADOS SIN CUPÓN-PRECINTO
TABLA I. Listado de principios activos
TABLA II. Listado de excipientes
TABLA III. Honorarios profesionales
TABLA IV. Precio de los envases

Anexo C. Procedimiento de facturación y pago

1. Normas previas a la facturación
2. Proceso de facturación
3. Presentación de la facturación
4. Revisión de la facturación
5. Procedimiento de pago
6. Anexos

Anexo D. Prestaciones con condiciones y procedimientos particulares

PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO

1. Procedimiento de dispensación

2. Condiciones económicas
3. Procedimiento de facturación
4. Actualización del Vademécum de principios activos

PRODUCTOS DIETOTERÁPICOS COMPLEJOS Y NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA

1. Procedimiento de dispensación
2. Condiciones económicas
3. Precio Máximo Financiado para la nutrición enteral domiciliaria y los tratamientos dietoterápicos complejos
4. Grupo técnico de trabajo
5. Facturación

ABSORBENTES DE INCONTINENCIA DE ORINA

1. Procedimiento de dispensación
2. Condiciones económicas
3. Facturación

TABLA V. Listado – Nomenclator de Dietas

CONCIERTO ENTRE EL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

Reunidos en Santander, a 23 de julio de 2008

De una parte la **Excmo. Sr. D. Luis María Truan Silva,** Consejero de Sanidad, y Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Cántabro de Salud, actuando en nombre y representación de dicho Organismo Autónomo con autorización del Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de fecha 5 de junio de 2008 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 k) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De otra, el **Ilmo**. **Sr. D. Francisco de Asís de la Maza Ruiz,** Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, en nombre y representación de los titulares de Oficinas de Farmacia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y a efectos de lo previsto en el artículo 8.1.e) de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria.

MANIFIESTAN

Que el presente Concierto entre el Servicio Cántabro de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, por el que se fijan las condiciones para la prestación farmacéutica a través de las Oficinas de Farmacia, ha sido elaborado con el criterio de desarrollar plenamente la actividad integral del farmacéutico garantizando una asistencia farmacéutica de calidad a la población mediante el establecimiento de unas pautas a seguir en un régimen amplio de colaboración con el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma.

Que ambas partes acuerdan suscribir el presente Concierto por el que se regulan las condiciones en que debe efectuarse la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en las Oficinas de Farmacia legalmente autorizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En su virtud, y reconociéndose ambas partes con competencia y capacidad legal, convienen suscribir el presente Concierto con arreglo a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

1. Objeto del Concierto

Este Concierto tiene por objeto la fijación de las condiciones en que debe efectuarse la prestación farmacéutica en las Oficinas de Farmacia legalmente establecidas en la Comunidad de Cantabria, de acuerdo con la legislación vigente y las especificaciones señaladas, que las partes firmantes del Concierto consideran de interés para el beneficiario del Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva de atención integral a la salud del ciudadano.

1.1. Establecer y regular el marco de colaboración en la Comunidad Autónoma de Cantabria, del Servicio Cántabro de Salud con las Oficinas de Farmacia de Cantabria, que determina la forma y condiciones de DISPENSACIÓN de medicamentos, efectos y accesorios, fórmulas magistrales, preparados oficinales y vacunas antialérgicas individualizadas, incluidas en la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Son asimismo objeto del Concierto los Tratamientos Dietoterápicos Complejos y la Nutrición Enteral Domiciliaria.

1.2. Implantar y coordinar el desarrollo progresivo de Programas de ATENCIÓN FARMACÉUTICA que se realicen en las Oficinas de Farmacia e incluyan tanto actividades orientadas al medicamento como al paciente. Entre otros, programas de prevención y promoción de la salud, detección de problemas relacionados con los medicamentos, sistemas de colaboración con el Centro de Farmacovigilancia de Cantabria y educación sanitaria. A través de mecanismos de colaboración siempre orientados a garantizar a la población el acceso eficaz y racional a los medicamentos y productos sanitarios.

2. Régimen Jurídico

El presente Concierto que tiene naturaleza jurídico administrativa se regulará por sus condiciones particulares, siendo de aplicación directa la normativa sanitaria estatal y autonómica por la que se regula la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud fundamentalmente la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo; la de la Seguridad Social en particular; así como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las normas autonómicas o resoluciones del Servicio Cántabro de Salud en materia de facturación de recetas.

Resultará aplicable subsidiariamente la legislación reguladora de la contratación del Estado así como toda aquella disposición legal que le sea de competencia.

3. Modelo de Atención Farmacéutica

La Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, define en su artículo 2 como Atención Farmacéutica el servicio público que se presta, bajo la responsabilidad y supervisión de un farmacéutico, con objeto de garantizar en todo momento una adecuada asistencia farmacéutica a la población, fomentando a su vez un uso racional del medicamento. En su artículo 4 señala la Oficina de Farmacia como el establecimiento de dispensación y asistencia a los ciudadanos dónde llevar a cabo dicha atención farmacéutica.

Todas las actividades de atención farmacéutica deben llevarse a cabo bajo la dirección, responsabilidad y presencia de un farmacéutico. Entre las distintas funciones asistenciales del profesional farmacéutico se distinguen:

- Las actuaciones orientadas al medicamento: adquisición, custodia, almacenamiento y conservación de materias primas, especialidades farmacéuticas y productos sanitarios.

- Las actividades orientadas al paciente: dispensación de especialidades farmacéuticas y productos sanitarios, elaboración de fórmulas magistrales, consejo farmacéutico, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, farmacovigilancia y seguimiento del tratamiento farmacológico de los pacientes.

La Dispensación de Medicamentos es la situación en la que una persona solicita un medicamento concreto, generalmente mediante una prescripción médica. La actuación profesional del farmacéutico además de la entrega del medicamento debe ir orientada a discriminar la posible existencia de problemas potenciales, e ir acompañada de instrucciones sobre la adecuada utilización del medicamento.

Los elementos indispensables para realizar una adecuada dispensación son la identificación de los profesionales de la farmacia por su titulación y que debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación en cuanto a la exigencia de receta médica.

El Consejo Farmacéutico se realiza cuando el paciente consulta al farmacéutico sobre el posible tratamiento para un problema de salud concreto. En este caso estará siempre referido a aquellos síntomas o síndromes menores para los cuales la legislación permite la dispensación de un medicamento sin prescripción médica (artículo 19.4. de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios) o bien, supondrá la derivación al médico en caso necesario.

Los elementos indispensables para realizar un adecuado consejo farmacéutico son cumplir los requisitos establecidos por la legislación en cuanto a la exigencia de receta médica.

El Seguimiento Farmacoterapéutico se realiza con el objetivo de conseguir la máxima efectividad de los medicamentos que el paciente ha de utilizar. Es la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación, de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales de la salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.

Los elementos indispensables para realizar el adecuado seguimiento farmacoterapéutico individualizado son el compromiso del farmacéutico con los resultados de la farmacoterapia en cada paciente, un acuerdo previo farmacéutico-paciente, y la recogida de información suficiente sobre las necesidades del paciente en relación con su farmacoterapia.

Asimismo una adecuada dispensación de medicamentos, consejo farmacéutico y seguimiento farmacoterapéutico debe cumplir la existencia de procedimientos normalizados de trabajo, el registro y documentación de las actividades realizadas, y la comunicación con otros profesionales sanitarios implicados en la atención a ese paciente.

En esta línea, cualquiera de las partes firmantes de este Concierto podrá proponer cuantas actividades y programas de Atención Farmacéutica estimen oportuno elaborando un Plan de Desarrollo y Seguimiento que contemple entre otros objetivo, planificación, procedimiento normalizado de trabajo, plazos de tiempo, recursos necesarios y localización de la actuación.

4. Condiciones de la Dispensación

Los acuerdos relativos a la dispensación que se establezcan en el presente Concierto se aplicarán de acuerdo con el régimen jurídico previsto en la Cláusula 2.

La dispensación de medicamentos, efectos y accesorios, fórmulas magistrales, preparados oficinales y vacunas antialérgicas individualizadas, en los términos establecidos en el punto 1.1. del objeto de este Concierto, se efectuará a través de todas las Oficinas de Farmacia legalmente establecidas en la Comunidad de Cantabria. Es condición inexcusable que la dispensación se realice bajo la dirección responsabilidad y presencia del farmacéutico y que la Oficina de Farmacia no se encuentre bajo sanción administrativa en relación con su actividad sanitaria.

Las características de dispensación y las condiciones de validez de las recetas se especifican en el Anexo A.

La elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales mediante los procedimientos y controles establecidos en la legislación vigente se regulará de acuerdo con lo indicado en el Anexo B, al igual que las condiciones para las Vacunas individualizadas y los Productos sin cupón-precinto sometidos a visado.

La dispensación y facturación de recetas médicas prescritas de Tratamientos Dietoterápicos Complejos y Nutrición Enteral Domiciliaria y de Absorbentes de

Incontinencia de Orina se establece en el Anexo D, que recoge las condiciones particulares de esta prestación farmacéutica en Cantabria.

De igual modo, con objeto de mejorar la asistencia farmacéutica por parte de las oficinas de farmacia de las diferentes Zonas Básicas de Salud de la Comunidad a los Centros de la Tercera Edad, el Servicio Cántabro de Salud establecerá los acuerdos pertinentes con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.

Por último, la progresiva implantación del Modelo de Receta Electrónica en Cantabria hará necesario adaptar las condiciones de dispensación recogidas en este Concierto de manera que se cumplan las características y condiciones acordadas. Una vez instaurada la receta electrónica en la Comunidad tendrá plena validez desde el mismo momento de su implantación y se incorporará a este Concierto un Anexo de Receta Electrónica.

5. Condiciones económicas

El Servicio Cántabro de Salud abonará a las Oficinas de Farmacia las recetas correctamente dispensadas y facturadas en las condiciones económicas siguientes:

5.1. Los medicamentos y los efectos y accesorios se valorarán de acuerdo con los precios legalmente autorizados, recogidos en el correspondiente Nomenclátor Oficial debidamente actualizado. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre aplicación de precios de referencia y de los acuerdos a que puedan llegar las Oficinas de Farmacia con el Servicio Cántabro de Salud en virtud de lo previsto en la Cláusula Adicional.

En caso de que se produzca una revisión de los precios de los medicamentos, efectos y accesorios, y con objeto de evitar perjuicios económicos a ambas partes, la valoración se llevará a cabo de conformidad con lo que establezca la normativa vigente.

5.2. Las condiciones económicas en materia de Absorbentes de Incontinencia de Orina se regirán por lo establecido en el Anexo D aplicándose en la facturación de estas dispensaciones una deducción del 13 % sobre el P.V.P.+I.V.A. Los Tratamientos Dietoterápicos Complejos y la Nutrición Enteral Domiciliaria se valorarán de acuerdo con los precios máximos de financiación correspondientes al Nomenclátor de Dietas del Servicio Cántabro de Salud, descritos en el Anexo D. En el caso de las recetas prescritas por principio activo, las condiciones económicas de la facturación de todas las recetas también se recogen en ese mismo anexo.

5.3. Las fórmulas magistrales, los preparados oficinales, las vacunas bacterianas y los extractos hiposensibilizantes se facturarán de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo B.

5.4. Por último, los productos sin cupón-precinto sometidos a visado se someterán a los requisitos de facturación que indica el Anexo B del presente Concierto.

6. Sistema de Información

La necesidad creciente de información para la adecuada Gestión de la Prestación Farmacéutica por parte del Servicio Cántabro de Salud y para la implantación de procesos de mejora continua de la asistencia farmacéutica prestada, requiere un adecuado conocimiento de los datos de facturación de las recetas médicas, tal como se recoge en el correspondiente apartado del Anexo C.

Por otra parte, la grabación mecanizada de dichos datos deberá adaptarse a la progresiva innovación tecnológica del Servicio de Salud. En este sentido, el presente Concierto incorpora la digitalización de las recetas médicas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.

7. Procedimiento de Facturación

La facturación de recetas con cargo al Servicio Cántabro de Salud será de los medicamentos, efectos y accesorios, fórmulas magistrales, preparados oficinales, vacunas antialérgicas individualizadas, productos dietoterápicos complejos y nutrición enteral domiciliaria incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Se efectuará a través de la mecanización informática de las mismas, según las condiciones de facturación del respectivo Anexo C, y de acuerdo a las condiciones económicas para prestaciones particulares del Anexo D.

El comienzo de la grabación y facturación de recetas, según lo establecido en el Anexo C del presente Concierto, se realizará en la facturación de recetas correspondiente al mes de agosto de 2008.

A fin de realizar actuaciones de verificación, el Servicio Cántabro de Salud procederá a la grabación de datos de las recetas de forma complementaria y no sustitutoria. Resultados de calidad de grabación no satisfactorios según lo establecido en la Cláusula 8 de este Concierto obligarán a la nueva lectura y facturación de las recetas por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

El coste de la facturación de recetas y de la digitalización de las mismas, será asumido íntegramente por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, que lo repercutirá entre las Oficinas de Farmacia.

La grabación de datos de las recetas contemplará las necesidades de información farmacéutica del Servicio Cántabro de Salud y se llevará a cabo en la forma y manera indicada con el fin de que sea compatible con la aplicación informática para Gestión de la Prestación Farmacéutica del Servicio Cántabro de Salud.

Al objeto de garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal, con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria solamente podrá disponer y utilizar la información procedente de la mecanización y digitalización de las recetas del Sistema Nacional de Salud para dar cumplimiento a las condiciones de facturación de las recetas que se establecen en el Anexo C. Cualquier otro uso deberá ser autorizado previamente por el Servicio Cántabro de Salud.

Las empresas susceptibles de ser contratadas o concertadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria para la grabación, digitalización, procesado y tratamiento de los datos contenidos en las recetas tienen expresamente prohibido cualquier uso de estos datos, excepto su entrega al Colegio en la modalidad expresada en el Anexo C. Estas condiciones deben figurar como cláusulas inexcusables en el contrato que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria establezca con la/s empresa/s correspondientes.

8. Procedimiento de pago

De la factura valorada a P.V.P. de facturación, legalmente establecido o pactado, se deducirá la parte correspondiente a la aportación del beneficiario que haya sido abonada por éste a la Oficina de Farmacia en el momento de la dispensación, el importe resultante de la aplicación de la normativa vigente en materia de márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. Asimismo, en la facturación de efectos y accesorios se aplicarán las deducciones acordadas en cada momento para los absorbentes de incontinencia de orina.

Una vez efectuada la facturación según se indica en el Anexo C, el Colegio Oficial de Farmacéuticos entregará a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud los siguientes documentos:

- Factura en papel (Anexo IV) que contenga la información económica extraída del tratamiento de las recetas tanto en listados individuales por oficina de farmacia como el importe suma del total facturado en Cantabria, cuyo plazo de presentación finaliza el día 10 del mes siguiente.
- Los soportes informáticos correspondientes a los datos generados por la información anterior (Anexos II y III, CD-ROM, Disco USB) deben recibirse con la mayor celeridad, entre el día 10 y el día 20 del mes siguiente, con las características y las condiciones de seguridad establecidas en el Anexo C.
- Las recetas médicas originales facturadas serán entregadas antes de finalizar el mes siguiente a la facturación. Por motivos justificados podrán ser en los primeros días del mes siguiente.

La forma y plazo de pago será la establecida en el Anexo C, cursándose órdenes de transferencia por la Dirección General de Tesorería, Presupuesto y Política Financiera del Gobierno de Cantabria antes del día 20 de cada mes, para el abono efectivo al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria de su correspondiente factura. Si el día 20 fuera inhábil, se cursará orden de pago el primer día hábil posterior al día 20.

A finales de los periodos anuales de facturación pudieran producirse desajustes presupuestarios que originen algún retraso en el pago del mes de Noviembre por parte de la Administración. Si esta circunstancia ocurriera, se modificaría el descuento aplicado a los absorbentes de incontinencia urinaria en la liquidación de la factura del mes siguiente reduciéndose el porcentaje de descuento en un 0.5 % por cada día de retraso. Si la demora en el pago fuera de una parte del líquido a abonar, la reducción se efectuará en la parte proporcional. A tal efecto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos certificará al Servicio Cántabro de Salud, tanto las fechas efectivas de cobro como los importes abonados por la Tesorería del Gobierno de Cantabria. Si esta circunstancia se presentara algún otro mes del año por cualquier motivo, se aplicaría la misma fórmula de descuento.

Este pago tendrá carácter no definitivo hasta que el Servicio Cántabro de Salud efectúe la validación de dicha factura mediante:

1. El análisis de la calidad de grabación de las recetas, si el Indicador de Calidad de Grabación superase el 4% de errores supondría la nueva mecanización de las recetas por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

2. Las comprobaciones de la facturación mediante la propia aplicación informática para la Gestión de la Prestación Farmacéutica del Servicio Cántabro de Salud, si se detectaran errores relevantes en la facturación de las recetas no conformes a

los precios de los Nomenclátor oficiales o acordados supondría la detracción de la cantidad no correcta en la factura farmacéutica del mes siguiente.

Tras la validación de la factura, el Servicio Cántabro de Salud emitirá certificación de la correcta facturación.

9. Seguimiento y cumplimiento

Se creará para tal fin una Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

9.1. Las funciones serán las siguientes:

1. Resolver las incidencias que vayan apareciendo en el procedimiento de la facturación y devolución de recetas.

2. Velar por el cumplimiento de este Concierto.

3. Promover la creación de las Comisiones Técnicas necesarias para el desarrollo de los aspectos recogidos en el presente Concierto.

4. Evaluar los Programas de Atención Farmacéutica que se desarrollen.

5. Promover y potenciar acuerdos de colaboración con las Oficinas de Farmacia en Programas de Uso Racional de los Medicamentos.

Si se detectara entrega de medicamentos y/o efectos y accesorios en los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Cántabro de Salud no conformes a la regulación vigente, emprenderán las actuaciones oportunas para, en los casos que sea preciso, proponer la cesación y corrección de las mismas.

9.2. Composición de la Comisión de Seguimiento:

a) Cuatro Vocales, designados por el Consejero de Sanidad. Uno de estos vocales será el Director Gerente del Servicio de Salud o persona en quien delegue, a quien corresponderá presidir esta Comisión. Al menos uno de los vocales pertenecerá a la Inspección Farmacéutica.

b) Cuatro Vocales designados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

c) Un Secretario, funcionario de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, con voz pero sin voto.

En caso de ser necesario personal técnico para aclarar algún tema relativo al seguimiento del Concierto y previa comunicación al Secretario de la Comisión, podrá convocarse para que asista a la reunión, con voz pero sin voto.

9.3. Régimen de la Comisión de Seguimiento:

La Comisión se reunirá, con carácter trimestral y, además, cuando así lo solicite una de las dos partes por causa justificada. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los vocales presentes, en caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente de la Comisión.

En caso de no producirse acuerdo será la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la que estudie el caso y emita informe de su decisión. Contra dicho informe podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Sanidad de Cantabria de conformidad con lo previsto en el artículo 28.1 del Estatuto del Servicio Cántabro de Salud, aprobado mediante Ley de Cantabria 10/2001de 28 de diciembre. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.3. de la misma Ley serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

10. Vigencia del concierto

10.1. Plazo de vigencia

El presente Concierto tendrá una duración de 4 años a partir del 1 de agosto de 2008, y se considerará prorrogado tácitamente por períodos anuales, si no lo denuncia ninguna de las partes, con tres meses de antelación a la fecha de su vencimiento.

La denuncia deberá formularse por escrito y notificarse a la contraparte de forma fehaciente con tres meses de antelación. A fin de evitar la interrupción de las prestación farmacéutica del S.N.S., el presente Concierto, aunque haya sido denunciado, seguirá siendo aplicado hasta el último día del mes anterior al de la entrada en vigor del nuevo Concierto o de la normativa que lo sustituya.

A la entrada en vigor del presente Concierto quedará sin efecto el Concierto firmado entre el Servicio Cántabro de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria el 13 de mayo de 2003.

10.2. Los Anexos sobre:

A- Condiciones de la Dispensación
B- Fórmulas magistrales, Vacunas individualizadas y Visados sin cupón precinto
C- Procedimiento de Facturación y Pago
D- Prestaciones con condiciones y procedimientos particulares

Se consideran incorporados al Concierto y formando parte integrante del mismo. Así como el Anexo de Receta Electrónica que entrará en vigor en el momento de su puesta en marcha en la Comunidad Autónoma.

10.3. Modificación de las condiciones del Concierto.

La modificación de la regulación legal o reglamentaria que afecte a las condiciones económicas actualmente vigentes en la prestación farmacéutica a través de las Oficinas de Farmacia, incluida la modificación de los márgenes profesionales, o la del procedimiento de facturación y pago pactado en este Concierto, podrá determinar su revisión a petición de cualquiera de las partes.
Las modificaciones normativas que, a criterio de ambas partes, no estén contempladas en el apartado anterior, se aplicarán desde su entrada en vigor, sin que para ello sea preciso modificar la redacción del Concierto. No obstante, la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica podrá adaptar los anexos de este Concierto a dichas modificaciones normativas.

La modificación de las condiciones económicas contempladas en el Anexo D para los Tratamientos Dietoterápicos Complejos y Nutrición Enteral Domiciliaria, los Absorbentes de Incontinencia Urinaria y las prescripciones por Principio activo podrá ser acordada por ambas partes sin que ello suponga la renovación del presente Concierto

firmado. Deberá quedar constancia de dichos acuerdos en la correspondiente Acta de la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

Iniciada la negociación y transcurridos 30 días naturales sin alcanzarse acuerdo, podrá formularse la denuncia del Concierto con el efecto correspondiente de rescisión, a los dos meses de ser formulada.

CLÁUSULAS ADICIONALES

Primera: Se podrán establecer acuerdos para la aplicación de otros Convenios de colaboración y prestación de servicios sanitarios y profesionales, entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Servicio Cántabro de Salud, en la línea de la prevención y promoción de la salud, información, seguridad y educación de la población sobre medicamentos, y orientados a la regulación de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios en centros sociosanitarios.

Segunda: Los firmantes se comprometen a participar activamente en la implantación y desarrollo de la receta electrónica para lo que habilitarán los recursos necesarios en su ámbito de actuación. Resulta de especial relevancia para el Servicio Cántabro de Salud potenciar este nuevo modelo de receta médica que supondrá una mejora significativa en la atención farmacéutica y sanitaria que se presta a la población, y aportará grandes ventajas al paciente de eficiencia, seguridad y comodidad.

CLÁUSULA TRANSITORIA

No existen casos pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de este Concierto.

CLÁUSULA FINAL

El presente Concierto entrará en vigor el día 1 de agosto de 2008.

En prueba de conformidad firman el presente Concierto y sus Anexos, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,

Por el Servicio Cántabro de Salud	**Por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria**
D. Luis María Truan Silva *Consejero de Sanidad de Cantabria*	D. Francisco de Asís de la Maza Ruiz *Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria*

ANEXO A.
Condiciones de la dispensación

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. Dispensación de recetas

1.1.1. Sólo serán dispensables con cargo al Servicio Cántabro de Salud las prescripciones de medicamentos, efectos y accesorios, formulación magistral y vacunas antialérgicas individualizadas que formen parte de la oferta financiable del Sistema Nacional de Salud, se efectúen en las correspondientes recetas oficiales y se ajusten a los requisitos generales de la normativa vigente y a lo establecido específicamente en este Concierto.

1.1.2. Serán facturables con cargo al Servicio Cántabro de Salud las recetas de Tratamientos Dietoterápicos Complejos y Nutrición Enteral Domiciliaria, y de Absorbentes de Incontinencia Urinaria que se ajusten a las características recogidas en este anexo y según las condiciones económicas recogidas en el Anexo D del presente Concierto.

1.1.3. Los farmacéuticos están obligados, dentro del horario reglamentariamente establecido y en los supuestos de urgencia, a efectuar la dispensación, siempre que el beneficiario presente una receta oficial que reúna los requisitos de validez que se señalan en este anexo y se abone la correspondiente aportación económica.

1.1.4. En las Oficinas de Farmacia se procederá de la siguiente forma:

La persona beneficiaria de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud se identificará mediante la correspondiente Tarjeta Sanitaria o documento acreditativo del derecho a dicha prestación y se comprobará que el tipo de usuario corresponde al modelo de receta presentado. El Servicio Cántabro de Salud colaborará en la información de los diferentes tipos de usuarios y los modelos de recetas en que va prescrito cada uno.

Asimismo revisará si la receta contiene el código de barras que identifica el Código de Identificación del Paciente (C.I.P.) ó el número de afiliación. En caso negativo, a la vista de la Tarjera Sanitaria del usuario, el farmacéutico consignará de forma manual el C.I.P. del paciente.

En el caso de recetas de accidentes de trabajo se comprobará que conste la empresa donde presta sus servicios el asegurado, domicilio de la empresa y mención expresa de que la protección del riesgo de accidente de trabajo corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En caso de dudas el farmacéutico se pondrá en contacto con el Servicio Cántabro de Salud para confirmarlo. Si la protección de este riesgo corresponde a una Entidad aseguradora distinta, el Servicio Cántabro de Salud no se hará cargo de su abono.

1.2.Precios de referencia

La dispensación y financiación de los medicamentos con precio de referencia se efectuará de acuerdo con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios, y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.

1.3.Sustitución de medicamentos

1.3.1. De acuerdo con la normativa vigente, con carácter excepcional, cuando por causa de desabastecimiento no se disponga en la oficina de farmacia del medicamento prescrito o concurran razones de urgente necesidad en su dispensación, el farmacéutico podrá sustituirlo por el de menor precio. En todo caso deberá tener igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación, y el farmacéutico informará al paciente sobre la sustitución y se asegurará que conozca el tratamiento prescrito por el médico.

El menor precio viene recogido en la normativa sobre precios de referencia y las sucesivas actualizaciones que se realicen.

1.3.2. En todos los casos el farmacéutico anotará, en el lugar correspondiente de la receta, el medicamento que dispense, la fecha, su firma y su rúbrica. No será necesaria dicha diligencia en el caso de las sustituciones previstas como obligatorias cuando un medicamento tiene un precio por encima de precio de referencia.

1.3.3. Quedarán exceptuados de esta posibilidad de sustitución aquellos medicamentos que, por razón de sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico, determine el Ministerio de Sanidad y Consumo. Así no procederán a la sustitución de los medicamentos a que se refiere la Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamento y productos sanitarios, así como de sus posteriores actualizaciones:

- Medicamentos biológicos: insulinas, hemoderivados, vacunas, medicamentos biotecnológicos.

- Medicamentos que contengan alguno de los siguientes principios activos (excepto administrados por vía intravenosa): Acenocumarol, Carbamazepina, Ciclosporina, Digoxina, Metildigoxina, Fenitoina, Litio, Teofilina, Warfarina, Levotiroxina.

- Medicamentos que contengan principios activos sujetos a Especial Control Médico o especial seguimiento: Derivados de la vitamina A (isotretinoína y acitretina de administración sistémica), Ácido acetohidroxámico, Talidomida, Clozapina, Pergolida, Cabergolina, Vigabatrina, Sertindol.

- Medicamentos para el aparato respiratorio administrados por vía inhalatoria.

1.4. Sustitución de efectos y accesorios

La sustitución de efectos y accesorios se regirá por criterios que garanticen idéntico resultado, y se realizará de manera similar a lo establecido para la sustitución de medicamentos.

1.5. Prescripción por principio activo

Las Administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los medicamentos identificados por su principio activo en la receta médica. Las especiales características de dispensación por principio activo para recetas del Servicio Cántabro de Salud se recogen en el Anexo D correspondiente de este Concierto.

2. RECETAS FACTURABLES

2.1. Serán facturables con cargo al Servicio Cántabro de Salud, todas aquellas recetas de medicamentos, y efectos y accesorios, incluidos en el correspondiente Nomenclátor Oficial, prescritos según la normativa vigente y que se encuentren provistos de cupón precinto.

También serán facturables las fórmulas magistrales y preparados oficinales, las vacunas bacterianas individualizadas, los extractos hiposensibilizantes y visado sin cupón precinto que se ajusten a las características recogidas en el Anexo B.

Asimismo serán facturables las recetas de productos dietoterápicos complejos y de nutrición enteral, y de absorbentes de incontinencia de orina según lo dispuesto en el Anexo D.

2.2. Aquellos medicamentos y productos sanitarios que precisen visado del Área de Inspección según la normativa vigente, serán únicamente dispensados cuando presenten el correspondiente visado de Inspección.

No son facturables, aunque lleven visado de Inspección, las recetas en las que se prescriba cualquier tipo de producto que, conforme a la normativa vigente, no forme parte de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

2.3. De acuerdo con el artículo 89.2. de la Ley 26/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios, se considerarán no incluidos en la financiación pública los medicamentos publicitarios, los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos, y otros productos similares.

2.4. Asimismo no podrán facturarse con cargo al Servicio Cántabro de Salud los medicamentos y fórmulas magistrales excluidos de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud, y en el Real Decreto 1663/1998, de 24 de julio, por el que se amplía la relación de medicamentos excluidos a efectos de su financiación con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la Sanidad.

2.5. No podrán dispensarse en una receta, ni por tanto facturarse conjuntamente, medicamentos, fórmulas magistrales, y efectos y accesorios.

2.6. En cada receta ordinaria únicamente podrá dispensarse un solo envase de medicamento, efecto y accesorio, fórmula magistral, vacuna alérgica individualizada, a excepción de:

- Grupo terapéutico J01 “Antibacterianos para uso sistémico”, del que se podrán prescribir de uno a cuatro envases unidosis por vía parenteral y hasta dos envases del resto de presentaciones, siempre que tengan la misma denominación común internacional, dosis, forma farmacéutica y formato. De los subgrupos J01E, J01M y J01R sólo se podrá prescribir un envase por receta.

- Insulinas en viales multidosis, de las que se podrán prescribir de uno a cuatro viales (no se incluyen los cartuchos multidosis, plumas...)

- Medicamentos de diagnóstico hospitalario, de las que se podrán prescribir de uno a cuatro envases, siempre y cuando no supere el tratamiento correspondiente a tres meses y no se hayan emitido instrucciones específicas desde el Servicio Cántabro de Salud.

- Tratamientos Dietoterápicos Complejos y Nutrición Enteral Domiciliaria podrán prescribirse en cada receta hasta cuatro envases del mismo producto, siempre y cuando no se supere la cantidad necesaria para cubrir un mes de tratamiento.

- Medicamentos considerados como estupefacientes, de las que se podrá prescribir de uno a cuatro envases, siempre y cuando no supere el tratamiento de treinta días.

- Cualquier otro medicamento que se determine legalmente en el futuro.

De los medicamentos que sin ser de diagnóstico hospitalario estén sometidos a visado sólo podrá dispensarse un envase por receta.

Todo ello sin perjuicio de los avances que fomentados por las Autoridades Sanitarias se produzcan hacia la mutiprescripción en una receta.

2.7. En las recetas para tratamiento de larga duración, únicamente podrán dispensarse los medicamentos que contengan los principios activos recogidos en el Anexo de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de mayo de 1994 sobre modelos oficiales de receta médica utilizadas para la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y sus sucesivas actualizaciones, que sean monofármacos y las asociaciones que se contemplan explícitamente en dicho Anexo. En todas estos medicamentos susceptibles de ser dispensados en tratamiento de larga duración figurarán estas siglas, T.L.D., dentro del cupón-precinto, salvo aquellos medicamentos, efectos y accesorios que se consideren necesarios para la realización de los programas sanitarios específicos referidos en el apartado b. del artículo sexto de dicha Orden.

En todo caso, en las recetas para T.L.D. se podrá dispensar hasta un máximo de cuatro envases, uno por cada uno de los cuerpos que forman dicha receta, a excepción de las insulinas en viales multidosis o aquellas otros que se determine legalmente.

2.8. Los farmacéuticos no dispensarán ningún medicamento ni producto sanitario cuando surjan dudas racionales sobre la validez de la receta médica presentada.

Desde el Servicio Cántabro de Salud se comunicará al Colegio de Farmacéuticos el robo o extravío de recetas, con el fin de que éste lo ponga en conocimiento de las oficinas de farmacia para que no sean dispensadas.

En relación con el artículo 5.3. de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de mayo de 1994 y lo dispuesto en el artículo 7.3. de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 25 de abril de 1994 que regula las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano, los farmacéuticos extremarán la cautela en el caso de prescripciones de estupefacientes y psicótropos, respetando y garantizando, no obstante, en todo caso, el derecho a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, comprobando previamente a su dispensación que la receta contenga los datos que permitan la identificación del prescriptor y paciente, según lo dispuesto en la normativa vigente.

2.9. Para la dispensación de las recetas, se verificará que en la prescripción figuren los datos básicos de identificación del medicamento o producto farmacéutico, del médico

prescriptor y del paciente. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, de receta médica, con la Orden de 23 de mayo de 1994 sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, y con las disposiciones legales que en el futuro regulen la receta médica.

2.9.1. Los **datos básicos del medicamento** para su correcta identificación se consideran: nombre, forma farmacéutica, dosis por unidad, presentación y vía de administración. No se considerará imprescindible para su identificación el que venga consignado el tamaño del envase siempre que no sea indispensable para su identificación inequívoca.

Para que las recetas oficiales en las que se prescriban vacunas bacterianas individualizadas y extractos hiposensibilizantes sean dispensables con cargo al Servicio Cántabro de Salud, en la prescripción deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos relativos al producto prescrito: identificación de cada uno de los antígenos con su composición cuantitativa y cualitativa, todo ello según las condiciones recogidas en el Anexo B

Con el fin de evitar perjuicios al paciente, y en tanto persistan recetas prescritas manualmente, excepcionalmente, tanto en el caso de medicamentos como de efectos y accesorios, podrán dispensarse aquellas recetas que carezcan de alguno de los siguientes datos:

- Forma farmacéutica, dosis por unidad, vía de administración, formato o presentación: sólo cuando esté garantizada su identificación inequívoca.

- Duración del tratamiento y posología: cuando no hayan podido ser cumplimentados tras constatar en el acto de la dispensación que el paciente ha sido informado, quedando avalada esta dispensación por la diligencia y firma del farmacéutico.
  Ante la falta de concordancia entre la duración de tratamiento con la posología y el tamaño que figura en la prescripción del medicamento, a efectos de validez de la receta tendrán prevalencia los datos de la prescripción, a no ser que el farmacéutico justifique lo contrario y lo diligencie en la receta**.**

- Fecha de prescripción: tras preguntar al paciente sobre la fecha en que le fue prescrito el medicamento y comprobar que no ha transcurrido el período de caducidad de la receta. El farmacéutico deberá diligenciar y firmar, en el apartado de advertencias al farmacéutico con la leyenda “receta sin fecha de prescripción: recibida dd/mm/aa”.
  En las recetas que presenten dos fechas (manuscrita e informática) prevalecerá, a efectos del cómputo del plazo de validez de las recetas la fecha manuscrita por el médico prescriptor.

2.9.2. Los **datos básicos de identificación del médico** para la dispensación de las recetas son: nombre y dos apellidos (ó inicial del nombre y un apellido si está consignado a mano), número de colegiado, fecha de prescripción y firma**.**

La falta de concordancia entre los datos de identificación del médico prescriptor que figuren en el espacio reservado a tal fin en la receta y los que consten en el código de barras bidimensional PDF 417, no será motivo de devolución.

2.9.3. Los **datos básicos de identificación del paciente** para la dispensación de las recetas son: nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento y número de afiliación ó código de identificación del paciente (C.I.P.)

Si la consignación viene realizada a mano sólo serán necesarios para la validez, los datos correspondientes al nombre y primer apellido, así como el número de afiliación ó código de identificación del paciente (C.I.P.)

El farmacéutico, comprobará que en dichos datos, aunque estén consignados de forma mecanizada, figura el C.I.P. (Código de Identificación del Paciente), y lo anotará a mano en caso de que no figure a la vista de la Tarjeta Sanitaria del usuario.

La ausencia de alguno de estos datos podrá ser completada por el farmacéutico, tal como recoge el punto 4.2.2.7

3. CONTROLES ESPECIALES: VISADO DE INSPECCIÓN

3.1. El Servicio Cántabro de Salud podrá establecer, con carácter especial, el visado de Inspección u otro tipo de medidas de control de naturaleza similar para la dispensación farmacéutica. Dicho visado constará del sello del Área de Inspección y Evaluación que recoge los siguientes elementos: Servicio Cántabro de Salud, código de principio activo, fecha de visado, número de envases visados, clave de visado (año/ localizador del visado) y firma.

A efectos de validez (abono de la receta) se considera indispensable en el visado el sello, la firma y la fecha. El Servicio Cántabro de Salud comunicará cualquier medida adoptada que modifique el visado al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria con la antelación suficiente para su eficaz implantación.

3.2. En las recetas para T.L.D. que precisen visado, éste deberá ir en cada uno de los cuerpos que forman esta receta.

3.3. La fecha del visado deberá ser igual o posterior a la de prescripción. La fecha de dispensación deberá ser igual o posterior a la de visado. En el caso de existir discordancias entre la fecha de prescripción y la fecha de visado se considerará como válida la fecha de visado.

Si en la receta no figura ni la fecha de prescripción ni la de visado, se deberá consultar con Inspección Médica y diligenciar con las indicaciones recibidas y la fecha.

3.4. El Médico Inspector, podrá completar, a la vista del informe del prescriptor, algún dato de la prescripción (forma farmacéutica, dosis, tamaño de envase), avalándolo con una nueva firma y sello complementario además de los ya existentes en el visado.

Ante la falta de concordancia entre la prescripción del médico y el nombre o número de unidades indicado en el sello de visado, el farmacéutico consultará con Inspección Médica y dispensará según lo indicado por ella, diligenciando la receta con las indicaciones recibidas y la fecha de la consulta.

3.5. El visado de Inspección avala la ausencia de fecha de prescripción de la receta y la ausencia de algún dato del producto o medicamento prescrito (dosis, forma farmacéutica, tamaño, etc.) cuando figure el código nacional en el visado. En el caso de enmiendas, añadidos o rectificaciones de la prescripción no salvadas por el médico (salvo el producto prescrito) podrán ser subsanadas por la Inspección Médica, con una nueva firma del Inspector.

El visado de Inspección no avala la dispensación de medicamentos no financiados por el Sistema Nacional de Salud ni un número mayor de envases que los permitidos en cada caso.

4. VALIDEZ DE LAS RECETAS

Serán válidas, a efectos de pago por el Servicio Cántabro de Salud aquellas recetas oficiales dispensadas por las oficinas de farmacia que cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente en este Concierto.

4.1. Plazo de validez

4.1.1. Las recetas tendrán un plazo de validez de diez días naturales, a partir de la fecha de prescripción que figure en la receta o, en su caso, en el visado. En las recetas de vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas bacterianas preparadas individualmente, por sus especiales características, se admitirá hasta un plazo de noventa días.

4.1.2. En las recetas para T.L.D., la primera dispensación deberá realizarse en los mismos plazos especificados en el apartado anterior. El resto de dispensaciones se realizarán conforme a la normativa vigente.

4.2. Causas de devolución de recetas

4.2.1. El Servicio Cántabro de Salud no se hará cargo y, por tanto, **no abonará aquellas recetas** en las que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1. Recetas sin el correspondiente cupón-precinto en el caso de medicamentos, efectos y accesorios, o sin justificante de la dispensación en los productos que carezcan de cupón-precinto, salvo en los supuestos en que se compruebe existencia de imposibilidad material. En el caso de productos sin cupón precinto la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica determinará el procedimiento de comprobación de la dispensación realizada.

2. Recetas con falta de coincidencia entre la prescripción y la dispensación, salvo en los supuestos de sustitución autorizados de conformidad con el punto 1.3. de este Anexo, o en aquellos casos en que, habiéndose producido intercambio de los cupones-precinto de las recetas de una farmacia, se observe coincidencia entre prescripción y dispensación.

3. Recetas que, precisando el correspondiente visado del Área de Inspección previo a la dispensación, no lo lleven en las condiciones establecidas en el punto 3 del presente Anexo.

4. Recetas con ausencia de los datos de consignación obligatoria por el médico prescriptor: nombre y dos apellidos, número de colegiado y firma. Excepcionalmente, en el caso de que estos datos fueran puestos a mano, la ausencia del segundo apellido y la presencia de la inicial del nombre no serán causa de devolución.

   La ausencia de la fecha de prescripción se adecuará a lo previsto en el punto 2.9.1. del presente Anexo.

   En el caso de recetas con visado, se ajustará a lo previsto en el punto 3 del presente Anexo, excepto si se trata de recetas sin la firma del médico.

5. Sólo serán motivo de devolución los añadidos, enmiendas o tachaduras del producto prescrito y de la fecha de prescripción no salvadas por la nueva firma del médico prescriptor o del Inspector responsable del visado como se contempla en el punto 3. No obstante, si las enmiendas en la fecha de prescripción no afectan a la correcta prescripción y dispensación de la receta dentro de los plazos de validez, no será necesario que estén salvadas por el prescriptor. _

6. Recetas en las que se acredite documentalmente su falsedad. En el caso de recetas extraviadas o robadas del Servicio Cántabro de Salud u otros Servicios de Salud, dicho Servicio informará al Colegio de Farmacéuticos de Cantabria y éste a las Oficinas de Farmacia, en el menor período de tiempo posible. Las recetas serán nulas desde el momento de la notificación del Colegio a las farmacias.

7. Recetas en que se prescriban fórmulas magistrales que no se ajusten a lo establecido en el correspondiente Anexo B de este Concierto.

8. Recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, siendo la Entidad aseguradora distinta de la Seguridad Social; así como recetas oficiales del Servicio Cántabro de Salud en las que el asegurado pertenezca a MUFACE, MUGEJU o ISFAS. En este caso se devolverán los originales de las recetas.

9. Recetas dispensadas de algún producto de los excluidos de la prestación farmacéutica.

10. Ausencia de la fecha de dispensación y fecha de dispensación anterior a la fecha de prescripción o visado en su caso.

11. Otras causas de devolución previamente tratadas por la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

4.2.3. El Servicio Cántabro de Salud no se hará cargo y, por tanto, **no abonará el margen de beneficio** profesional del farmacéutico, en aquellas recetas en las que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1. Recetas dispensadas después del plazo de validez de 10 días naturales, desde la fecha de prescripción o visado, con las excepciones contempladas en el punto 4.1.1 del presente Anexo (vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas bacterianas)

2. Recetas facturadas después de noventa días de su dispensación, salvo en los casos de subsanación expresamente contemplados en este Anexo, para los cuales se establecerá un plazo adicional de sesenta días, contados desde el día siguiente al de la devolución por el Servicio Cántabro de Salud, pasado el cual no podrá ser presentada de nuevo.

3. Recetas en las que figure cuantificado numéricamente que la duración del tratamiento prescrito es superior a tres meses, o bien no figure cuantificado y no esté diligenciado por el farmacéutico.

4. Ausencia de la diligencia y firma del farmacéutico en aquellas recetas en las que no figuren los datos de consignación obligatoria relativos a la prescripción previstos en el punto 2.9.1. de este Anexo.

5. Ausencia de la diligencia y firma del farmacéutico en aquellas recetas en las que no figure la fecha de prescripción ni la fecha de visado tras consulta a la Inspección Médica del Servicio Cántabro de Salud recogiendo las indicaciones recibidas en el apartado de advertencias al farmacéutico.

6. Ausencia de la diligencia y firma del farmacéutico en el caso de sustituciones autorizadas de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 26/2006, de 26 de julio de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

7. Ausencia de alguno de los datos de consignación obligatoria relativos al paciente: nombre y dos apellidos y número de afiliación ó código de identificación del paciente (C.I.P.)
   La ausencia del dato correspondiente al nombre y apellido del asegurado, o al número de afiliación ó código de identificación del paciente (C.I.P.), podrá ser completado por el farmacéutico, tal como se recoge en el punto 2.9.3. del presente Anexo.

8. Ausencia de la fecha de prescripción sin diligenciar de acuerdo con el punto 2.9.1. del presente Anexo.

9. Fecha de dispensación posterior al cierre de facturación.

10. Recetas en las que, sin diligencia del farmacéutico, se dispense un tamaño del envase menor al prescrito o un sólo envase cuando se prescriba más de uno, se abonará el importe del producto dispensado descontando el margen de beneficio profesional. Esta causa de nulidad de margen no se aplicará cuando se compruebe, de forma suficiente, que nunca ha sido comercializado por el laboratorio o su inexistencia en los canales de distribución habituales.

11. Recetas para T.L.D. en los que se prescriba un producto no dispensable en este tipo de receta.

12. Recetas prescritas por principio activo facturadas en "Principio Activo. Desabastecimiento" en las que se comprueba que la situación de desabastecimiento no es real, lo que será comunicado previamente a la Comisión de Seguimiento.

13. Otras causas de devolución previamente tratadas por la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

4.2.3. El S.C.S. considera como **nulas parciales** las recetas en las que se produzcan las siguientes incidencias:

1. Recetas en que se haya dispensado el tamaño mayor del envase, tanto en el caso de medicamentos como en el de efectos y accesorios, cuando en la prescripción figure uno menor o no figure, serán abonados con el importe correspondiente al envase menor, a no ser que se compruebe, de forma suficiente, su inexistencia en los canales de distribución habituales. Esta causa de nulidad parcial no se aplicará cuando no figure el tamaño del envase, pero la posología y duración de tratamiento debidamente cuantificados por el médico justifiquen el envase dispensado.

2. En las recetas de fórmulas magistrales en que la cantidad de los productos dispensada exceda de la máxima autorizada, sólo se abonará el importe de la cantidad máxima estipulada.

3. En los casos en que se dispense más de un envase aunque lleven visado, con las excepciones que se señalan en el punto 2.6. de este Anexo, sólo se abonará el importe de uno de ellos

4. Las recetas facturadas a precio diferente al establecido en este Concierto, serán abonadas al precio legalmente autorizado, que vendrá recogido en el correspondiente Nomenclátor Oficial en el caso de medicamentos, y de efectos y accesorios, y en los correspondientes Anexos de este Concierto en el caso de fórmulas magistrales, dietoterápicos, etc.

5. Recetas prescritas por principio activo y facturadas fuera de su tipo de dispensación, se abonará el Precio Menor Operativo salvo que se confirme que es reiterado e intencionado, lo que será comunicado previamente a la Comisión de Seguimiento.

4.2.4. El S.C.S. considera como recetas incursas en causas de **devolución subsanables**, aquéllas en las que se den las siguientes circunstancias:

1. La ausencia de la firma y/o los datos de identificación de la Oficina de Farmacia será subsanable y, por tanto, se devolverán las recetas a la farmacia para su cumplimentación, siempre que no se trate, en ningún caso, de más de 50% de las recetas facturadas por esa farmacia. En caso contrario, se procederá a la anulación de las mismas.

2. Los añadidos, enmiendas o tachaduras en los datos de identificación de la farmacia y fecha de dispensación, no salvadas por la diligencia del farmacéutico, se remitirán a la Oficina de Farmacia para la cumplimentación y subsanación de las recetas, siempre que no se trate, en ningún caso, de más de 50% de las recetas facturadas por esa farmacia. En caso contrario, se procederá a la anulación de las mismas.

3. Ausencia de los datos de valoración en fórmulas magistrales, según lo recogido en el Anexo B correspondiente, siempre que no se trate, en ningún caso de más del 50% de las recetas facturadas por esa farmacia. En caso contrario se procederá a la anulación total de las mismas.

4. Recetas de vacunas individualizadas, antialérgicas, bacterianas y autovacunas que no lleven al dorso la composición cuali y/o cuantitativa.

ANEXO B.
Fórmulas Magistrales, Vacunas individualizadas y Visados sin cupón precinto

El presente Anexo regula las condiciones que regirán la dispensación con cargo al Servicio Cántabro de Salud en lo concerniente a formulación magistral, vacunas individualizadas antialérgicas, vacunas individualizadas bacterianas y visados sin cupón precinto, así como las condiciones económicas en que se concierta este apartado de la prestación farmacéutica.

FÓRMULAS MAGISTRALES

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El contenido del presente apartado se adaptará al desarrollo de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, al Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud, a la Orden Ministerial de 14 de febrero de 1997 que establece determinados requisitos en la prescripción y dispensación de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales para tratamientos peculiares, al Real Decreto 1663/1998, de 24 de julio, por el que se amplía la relación de medicamentos excluidos a efectos de su financiación con cargo a los fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a Sanidad, al Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales, y demás normativa a nivel estatal o autonómico.

El establecimiento y actualización de manera transitoria de las condiciones económicas de las fórmulas magistrales será competencia del grupo de trabajo técnico que a tal efecto determine la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

2. FÓRMULAS MAGISTRALES INCLUIDAS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Las fórmulas magistrales con cargo al Servicio Cántabro de Salud serán las que se elaboren con principios activos y excipientes contenidos en el Formulario Nacional y en los listados de la tabla I, en la vía de administración que garantice la eficacia, seguridad y calidad de la fórmula, y en las condiciones particulares que se especifiquen para cada sustancia.

3. FÓRMULAS MAGISTRALES EXCLUIDAS DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

3.1. Fórmulas magistrales en cuya prescripción no conste la composición cualitativa y cuantitativa y/o no se haga referencia al Formulario Nacional o a la Farmacopea vigente en España. En caso de que no figure la cantidad a preparar, se abonará la correspondiente al primer tramo de honorarios.

3.2. Fórmulas magistrales que no hayan sido elaboradas por el farmacéutico que las factura o bajo su directa responsabilidad y dirección.

3.3. Fórmulas magistrales en cuya elaboración haya sido utilizado un medicamento de uso humano y fabricación industrial. Los casos excepcionales se someterán provisionalmente a la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

3.4. Fórmulas magistrales cuya composición, dosis, y forma farmacéutica sea idéntica a la de algún medicamento de uso humano y fabricación industrial registrado y comercializado en el mercado. En caso de que el farmacéutico, por error, dispense y facture dichas fórmulas magistrales, se abonará el preparado de menor precio.

3.5. Fórmulas magistrales cuya composición y/o indicación se corresponde con formulaciones retiradas en Programas de Selección y Revisión de Medicamentos del Ministerio de Sanidad y Consumo (PROSEREME) y/o fórmulas magistrales cuya composición se corresponde con medicamentos no financiados por el Sistema Nacional de Salud, así como aquellas retiradas del mercado por motivos de seguridad.

3.6. Fórmulas magistrales que incluyan excipientes solos o mezclas de los mismos, cuya finalidad sea únicamente servir de vehículo.

3.7. Fórmulas magistrales en cuya facturación no se haya consignado, en la receta, el procedimiento de valoración contemplado en el punto 10 del presente Anexo. La ausencia de estos datos será subsanable y, por tanto, se devolverán las recetas a la Oficina de Farmacia para su cumplimentación y subsanación, siempre que no se trate, en ningún caso, de más del 50% de las recetas de fórmulas magistrales facturadas por esa Oficina de Farmacia. En caso contrario, se procederá a la anulación total de las mismas.

3.8. Fórmulas magistrales que incluyan principios activos de acción e indicación no reconocida en España.

3.9. Las fórmulas magistrales que no cumplan las condiciones particulares que se especifican para cada sustancia expresadas en la lista de principios activos.

3.10. Quedan excluidos, igualmente, los productos dietéticos, de régimen, aguas mineromedicinales, vinos medicinales, elixires, dentífricos, cosméticos, artículos de confitería medicamentosa, jabones medicinales y demás productos análogos.

4. ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN

4.1. El proceso de preparación de las fórmulas magistrales y/o preparados oficinales se realizará según las normas técnicas y científicas, y según arte. Será de aplicación la normativa prevista en el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, relativa a las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales, y la demás normativa que se establezca al respecto por el Ministerio de Sanidad y Consumo o la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

4.2. Las fórmulas magistrales se dispensarán en envases adecuados a su naturaleza y al uso al que estén destinados, de forma que garanticen la protección del contenido y el mantenimiento de la calidad del mismo durante el tiempo de validez establecido por el farmacéutico elaborador.

4.3. La dispensación irá acompañada de la información suficiente que garantice su correcta identificación, conservación y utilización.

Esta información estará constituida por los datos que figuren en la etiqueta y por los que se incluyan en el prospecto, que deberán ser conformes al contenido de las monografías del Formulario Nacional.

Las etiquetas de los envases de fórmulas magistrales se ajustarán a los modelos establecidos en el Formulario Nacional, estarán expresados con caracteres fácilmente legibles, claramente comprensibles e indelebles, y contendrán los siguientes datos en el acondicionamiento primario.

- ASSS
- Denominación de la fórmula magistral o preparado oficinal (si la fórmula esta tipificada, deberá coincidir con la establecida en el Formulario Nacional)
- Composición cualitativa y cuantitativa completa, al menos, de los principios activos y excipientes de declaración obligatoria.
- Forma farmacéutica, Vía de administración y Cantidad dispensada.
- Nº de Lote, en el caso de preparados oficinales.
- Fecha de elaboración.
- Plazo de validez o fecha de caducidad.
- Condiciones de conservación (si procede)
- Nombre y número de colegiado del facultativo prescriptor.
- Nombre del paciente.
- Oficina de farmacia dispensadora (nombre, número, dirección y teléfono)
- Oficina de farmacia elaboradora (nombre, número, dirección y teléfono)
- Número de registro en el libro recetario, o soporte que lo sustituya, de acuerdo con la legislación vigente.
- Advertencia: “Manténgase fuera del alcance de los niños”.
- Observaciones (si procede)
- P.V.P.- IVA.

Cuando las dimensiones del envase no permitan la inclusión de todos estos datos en la etiqueta, estos se integrarán en hoja aparte, debiendo figurar obligatoriamente en la etiqueta:

- Denominación de la fórmula magistral o preparado oficinal
- Composición (cualitativa y cuantitativa) de al menos los principios activos y excipientes de declaración obligatoria.
- Nombre del paciente.
- Vía de administración, si puede existir confusión.
- Número de registro en el libro recetario.
- Número de Lote en caso de preparados oficinales.
- Fecha de elaboración y plazo de validez o fecha de caducidad.
- Oficina de farmacia dispensadora (nombre, número, dirección y teléfono)

4.4. En el acto de la dispensación de la fórmula magistral, el farmacéutico proporcionará al paciente la información oral y escrita, necesaria y suficiente, para garantizar su correcta identificación, conservación y utilización, así como la adecuada observancia del tratamiento, adecuándose la información escrita al paciente al Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, relativa a las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales

5. VALORACIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

Las fórmulas magistrales se valorarán de acuerdo con el procedimiento y las normas que se establecen en el punto 9 del presente Anexo. Se consideran englobados en el importe de las fórmulas magistrales, el precio de las materias primas, material de acondicionamiento y honorarios profesionales, así como los correspondientes impuestos.

6. APORTACIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

La aportación de los beneficiarios con derecho a prestación farmacéutica en las dispensaciones de fórmulas magistrales, será en cada momento la que determine la Administración Sanitaria competente.

Como distintivo, los principios activos que se formulen como monofármacos y les corresponda aportación reducida, irán señalados como tal en la lista de principios activos de la Tabla I.

La aportación económica del beneficiario de la Seguridad Social será abonada a la farmacia que dispense la receta sobre el P.V.P. con I.V.A. y figurará con el P.V.P.-I.V.A. de la fórmula magistral en el dorso de la receta.

7. FACTURACIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

Las fórmulas magistrales y preparados oficinales financiados se facturarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo de procedimiento de facturación y pago del vigente Concierto, y sólo se financiarán por el Servicio Cántabro de Salud las cantidades máximas establecidas por receta para cada forma farmacéutica.

8. LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS

8.1. La lista de principios activos así como la vía de administración, y demás condiciones particulares para ser incluidas en la prestación farmacéutica del Servicio Cántabro de Salud como fórmulas magistrales, se reflejan en la Tabla I. Los principios activos nunca serán dispensables a granel.

8.2. Fijación de precios del listado de principios activos.

La determinación de los precios de los principios activos incluidos en la Tabla I se efectuará a partir de los comprobantes o certificados originales acreditativos de los precios de coste emitidos por proveedores representativos, preferentemente en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Cantabria (centros farmacéuticos, cooperativas farmacéuticas, almacenes de distribución farmacéutica y almacenes de productos químicos)

8.3. Revisión de precios y productos de la lista de principios activos.

Cualquier inclusión, exclusión o modificación de las condiciones de la Tabla I, será competencia del grupo técnico de trabajo establecido al efecto por la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica, a solicitud de cualquiera de las partes.

9. NORMAS DE VALORACIÓN

9.1. Fórmulas magistrales

El precio de venta al público de las fórmulas magistrales con cargo al Servicio Cántabro de Salud se calculará de la forma siguiente:

- Se tomará en primer lugar el **precio de los principios activos** que conste en el listado de principios activos, calculando el importe en función de la cantidad empleada. Tabla I.

- A continuación, se añadirá el **precio del excipiente** correspondiente que figura en el listado de los excipientes. Tabla II.

La inclusión en la fórmula de productos químicos no reseñados en la lista de principios activos, ya sea como coadyuvantes de otros que si figuren en dicha lista o como excipientes, no supondrá la exclusión de la fórmula. En estos casos, el precio de estos productos se considerará incluido en el del excipiente.

- Se añadirá seguidamente, el **precio de los honorarios profesionales** que figura en la Tabla III de honorarios profesionales.

En la Tabla III "Honorarios profesionales" se fija la cantidad máxima a elaborar con cargo al Servicio Cántabro de Salud, expresada en peso, volumen, unidad, etc. En el caso de que se dispensen cantidades superiores se abonará únicamente la cantidad máxima.

Como criterio de valoración de cada grupo se mantiene el Factor P (constante) seguido de un coeficiente multiplicador variable que se fija en función de la complejidad en la preparación de cada forma farmacéutica.

Dicho factor se revisará anualmente de forma automática de acuerdo con el incremento del IPC anual, siendo de aplicación para las fórmulas dispensadas a partir del mes siguiente del conocimiento de estos datos. Este factor tiene un valor de 3,1260 euros a partir de la entrada en vigor del presente Concierto.

- Finalmente se añadirá el **precio del envase** de acuerdo con lo establecido en la Tabla IV.

- Al precio resultante debe **añadirse el IVA** vigente para los medicamentos.

En la receta médica deberá ponerse el sello:

500017 FÓRMULAS MAGISTRALES APORTACIÓN NORMAL
500058 FÓRMULAS MAGISTRALES APORTACIÓN REDUCIDA

Y consignarse el precio total de facturación final. Al dorso de la receta se consignará el precio desglosado de la siguiente forma:

materias primas: principios activos y excipientes +
honorarios profesionales + envase + IVA.

VACUNAS ANTIALÉRGICAS INDIVIDUALIZADAS

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de usio humano fabricados industrialmente, se considerarán a efectos de su dispensación con cargo al Servicio Cántabro de Salud como vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas bacterianas, aquellas preparadas con agentes inmunizantes, a concentración y dilución específica en base a la correspondiente prescripción facultativa para un paciente determinado, de acuerdo con la normativa vigente.

Las vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas bacterianas que estén autorizadas para su dispensación con cargo al Servicio Cántabro de Salud, llevarán una etiqueta, dónde se recoja el nombre y composición cualitativa y cuantitativa completa del preparado, datos del paciente, así como el P.V.P.-IVA, cuya finalidad será unirse a la receta oficial en el momento de la dispensación.

Se aceptarán en la facturación con cargo al Servicio Cántabro de Salud aquellas vacunas antialérgicas que tengan en su composición los alergenos que a continuación se citan: ácaros, polvo, pólenes, hongos, epitelios y mezclas de antígenos compatibles (hongos-polvo y ácaros- polvo)

Asimismo, se incluyen todas las vacunas individualizadas bacterianas, y aquellas vacunas individualizadas antialérgicas que en su composición entren alergenos distintos a los anteriormente citados, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos con carácter general.

Para la dispensación de todas las vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas bacterianas será preciso el visado de Inspección, en las condiciones previstas en el Anexo A. Cualquier modificación sobre este requisito será comunicada por el Servicio Cántabro de Salud con, al menos, 60 días de antelación al Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Para que las recetas oficiales en las que se prescriban vacunas individualizadas antialérgicas o vacunas individualizadas bacterianas tengan validez y puedan ser dispensadas con cargo al Servicio Cántabro de Salud, en la prescripción se especificará cada uno de los antígenos con su composición cualitativa y cuantitativa. En caso de que en las recetas no conste la composición cualitativa y cuantitativa, el farmacéutico adherirá a las mismas, en el momento de la facturación, copia o fotocopia del documento de solicitud del laboratorio preparador o, en su defecto, especificará al dorso de las recetas el o los alergenos correspondientes a la vacuna individualizada antialérgica o vacuna individualizada bacteriana.

La aportación de las vacunas antialérgicas y vacunas individualizadas será la legalmente establecida que en la fecha del presente Concierto es del 40% para recetas de activos y exenta para las recetas de pensionistas.

Para su facturación y, como comprobante de la dispensación, se adherirá a la receta la etiqueta autoadhesiva remitida por el laboratorio, en la que conste el nombre de la vacuna y P.V.P. -IVA, y además, se pondrá el sello:

500009 EXTRACTOS

VISADOS SIN CUPÓN-PRECINTO

Los productos sin cupón-precinto (Medias de compresión normal y Tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre) y sometidos a visado de Inspección tendrán la aportación que expresamente determine la Administración, debiendo ser comunicado con, al menos, 60 días de antelación al Colegio Oficial de Farmacéuticos.

La aportación a pagar por el usuario, en el caso de las medias de compresión normal, será la legalmente establecida, que en la fecha del presente Concierto es del 40% para recetas de activos y exenta para las recetas de pensionista. En el caso de las tiras reactivas la aportación será de 0,45€ para recetas de activos y exenta para recetas de pensionista.

A efectos de facturación, estas recetas deberán llevar justificante de la dispensación (fragmento del cartonaje en que figure el nombre y precio del producto), salvo en los supuestos en que se compruebe existencia de imposibilidad material, y la correspondiente etiqueta o sello:

500041	MEDIAS DE COMPRESIÓN NORMAL
500033	TIRAS REACTIVAS

TABLA I: LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	13-CIS-RETINOICO ÁCIDO = Isotretionina = Retinoico ácido 13,-CIS	(vía oral, ECM, visado de Inspección)		36,004
X	5-FLUOROURACILO	(sólo por vía tópica)	**SI**	3,744
	5-AMINO SALICÍLICO ÁCIDO =Mesalazina = 5 ASA		**SI**	0,3705
	5-ASA = 5 Aminosalicílico ácido = Mesalazina		**SI**	0,3705
X	8 METOXIPSORALENO = Metoxaleno		**SI**	5,9616
X	ACEITE CADE = Aceite Enebro = Brea Enebro	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0448
X	ACEITE ENEBRO = Aceite de cade = Brea Enebro	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0448
	ACETAZOLAMIDA			0,3772
	ACÉTICO ÁCIDO MEDICINAL	(como monofármaco para uso otológico)		0,0241
	ACETILSALICÍLICO ÁCIDO			0,0163
	ACETOHIDROXÁMICO ÁCIDO	(ECM, visado de Inspección)	.	4,6583
X	ACICLOVIR			2,4703
	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		2,3424

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	ALOPURINOL		**SI**	0,1736
	ALQUITRÁN HULLA = Brea Hulla = Coaltar		**SI**	0,0332
	ALQUITRÁN VEGETAL = Brea vegetal = Brea Pino	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0229
	ALUMINIO FOSFATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0152
	ALUMINIO HIDRÓXIDO POLVO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,03101
	ALUMINIO SILICATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0093
	AMANTADINA CLORHIDRATO			0,7601
X	AMILOCAÍNA CLORHIDRATO			1,5394
X	AMINOFILINA			0,1756
	5-AMINO SALICÍLICO ÁCIDO = Mesalazina = 5 ASA		**SI**	0,3705
	AMIODARONA CLORHIDRATO		**SI**	2,9911
	AMITRIPTILINA		**SI**	0,7344
	AMLODIPINO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**Si**	
	AMOXICILINA TRIHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		0,2354
	AMPICILINA TRIHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		0,552

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	ANTRALINA = Ditranol			2,6616
	5 ASA = 5-AMINO SALICÍLICO ÁCIDO = Mesalazina		**SI**	0,3705
X	ASCÓRBICO ÁCIDO = Vitamina C	(como monofármaco sólo vía parenteral)		0,0399
	ASTEMIZOL			4,9034
	ATENOLOL		**SI**	3,8324
X	ATROPINA SULFATO	(como monofármaco)		2,4801
	AZUFRE COLOIDAL			0,013
	AZUFRE LAVADO			0,0114
	AZUFRE PRECIPITADO			0,0143
	AZUFRE SUBLIMADO			0,0076
	AZUL DE METILENO = Metiltionina Cloruro	(sólo por vía sistémica)		0,3622
X	BECLOMETASONA DIPROPIONATO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)	**SI**	41,1435
	BENCIDAMINA CLORHIDRATO			0,4468
	BENCILO BENZOATO	(vía tópica sólo en concentraciones del 10% al 30%)		0,0311

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	BETAMETASONA	(como monofármaco, o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		24,5983
X	BETAMETASONA DIPROPIONATO	(como monofármaco, o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		12,6752
X	BETAMETASONA VALERATO	(como monofármaco, o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		16,544
	BIFONAZOL	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		4,6461
	BIOAZUFRE FLUIDO			0,0754
	BIOAZUFRE POLVO			0,0314
X	BIOTINA = Vitamina H	(como monofármaco)		8,112
	BISMUTO DICITRATO TRIPOTASIO = Bismuto subcitrato = tripotasio dicitrato Bismuto	(como monofármaco)		2,2554
	BISMUTO SUBCITRATO = Bismuto dicitrato tripotasio = Tripotasio dicitrato Bismuto	(como monofármaco)		2,2554
X	BISMUTO, SUBNITRATO			0,0935
	BÓRICO ÁCIDO POLVO	(como monofármaco para uso otológico)		0,0102

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	BREA ENEBRO = Aceite cade = Aceite enebro	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0448
	BREA HULLA = Alquitrán Hulla = Coaltar		**SI**	0,0332
	BREA PINO = Brea Vegetal = Alquitrán vegetal	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0229
	BREA VEGETAL = Alquitrán vegetal = Brea de pino	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0229
	BROMHEXINA CLORHIDRATO	(como monofármaco para utilización en EPOC y enfermedades asociadas según clasificación Internacional de Enfermedades 9ª edición)		0,4979
	BROMOCRIPTINA MESILATO		**SI**	52,5136
X	BUMETANIDA		**SI**	17,5531
X	BUTILESCOPOLAMINA BROMURO = Escopolamina Butil Bromuro	(como monofármaco)		41,5751
OX	CALCIFEROL = Ergocalciferol = Vitamina D = Vitamina D2	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		39,8674
	CALCIO ACETATO	(como monofármaco para el tratamiento de la hiperpotasemia e hiperfosfatemia)	**SI**	0,081
	CALCIO CARBONATO PRECIPITADO	(como monofármaco)		0,006
	CALCIO CITRATO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0502
X	CALCIO CLORURO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0267
	CALCIO FOSFATO DIBÁSICO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,007

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	CALCIO FOSFATO MONOBÁSICO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0161
	CALCIO FOSFATO TRIBÁSICO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0319
	CALCIO GLICEROFOSFATO = Glicerofosfato cálcico	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0455
	CALCIO GLUCONATO = Gluconato Cálcico	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0213
	CALCIO HIDRÓXIDO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0231
	CALCIO LACTATO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0213
	CALCIO SULFATO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0517
	CANRENONA	(sólo por vía tópica y como monofármaco)		5,1418
	CAPTOPRILO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**SI**	2,4149
	CARBAMAZEPINA		**SI**	1,3478
	CARBÓN ACTIVADO = Carbón adsorbente	(sólo como antídoto)		0,0677
	CARBÓN ADSORBENTE = Carbón activado	(sólo como antídoto)		0,0677
X	CIANOCOBALAMINA = Vitamina B12	(como monofármaco)		25,9161
	CICLOPIROX ETANOLAMINA	(excepto asociado a otros p.a.)		6,2784
X	CICLOSPORINA	(vía oftálmica)		46,7259

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	CIMETIDINA	(sólo por vía sistémica)		0,2683
	CIPROHEPTADINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		1,6819
	CIPROTERONA ACETATO	(sólo por vía sistémica)	**SI**	35,9916
	CITRATO SÓDICO = Sodio citrato			0,0176
	CLINDAMICINA CLORHIDRATO	(como monofármaco)		1,6579
X	CLIOQUINOL = Cloroiodoquina = Iodoclorhidroxiquinoleina	(vía tópica y sólo asociado a otros p.a.)		0,3899
X	CLOBETASOL PROPIONATO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		19,456
X	CLONIDINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)	**SI**	19,552
X	CLORANFENICOL PALMITATO	(vía oftálmica. Como monofármaco)		0,279
X	CLORANFENICOL SUCCINATO	(vía oftálmica. Como monofármaco)		0,2688
	CLORAZEPATO DIPOTÁSICO			1,4583
X	CLORDIAZEPÓXIDO	(como monofármaco)		0,7812
X	CLORFENAMINA MALEATO	(como monofármaco)		0,505
X	CLOROIODOQUINA = Clioquinol = Iodoclorhidroxiquinoleina	(vía tópica y sólo asociado a otros p.a.)		0,3899

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	CLOROTIAZIDA		**SI**	1,5381
X	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociados a ansiolíticos)	**SI**	0,3776
	CLORPROPAMIDA	(como monofármaco)	**SI**	0,042
	CLORTALIDONA		**SI**	1,1316
	CLOTRIMAZOL	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		0,425
	CLOXACILINA SÓDICA	(sólo por vía sistémica)		0,6007
	COALTAR = Alquitrán de Hulla = Brea de Hulla		**SI**	0,0332
	COBRE, SULFATO CRISTAL			0,0535
	COBRE, SULFATO POLVO			0,0562
X	CODEÍNA	(como monofármaco o asociado a otros analgésicos)		1,2983
X	CODEÍNA FOSFATO	(como monofármaco o asociado a otros analgésicos)		2,0465
OX	COLECALCIFEROL = Vitamina D3	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		13,6064
	COLESTIPOL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		
X	CRISAROBINA			1,1259
	CROMOGLICATO DISÓDICO = Sodio cromoglicato		**SI**	1,7185

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	DESOXIMETASONA	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		44,544
X	DEXAMETASONA	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Por vía oral en concentraciones iguales o mayores a 4mg. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		10,6048
X	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		13,2392
	DICLORISONA ACETATO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		28,5936
	DICLOXACILINA SÓDICA	(sólo por vía sistémica)		0,4201
X	DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,1946
	DIFENILHIDANTOÍNA = FENITOÍNA		**SI**	0,3052
	DIFLUCORTOLONA VALERATO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		90,3296
X	DILTIAZEM CLORHIDRATO		**SI**	4,7779

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	DIÓXIDO DE TITANIO = (Tioveil AQN)	(en casos de Lupus Eritematoso. Visado de inspección)		0,0447
X	DITRANOL = Antralina			2,6616
X	DOXICICLINA	(sólo por vía sistémica)		0,4413
	ECONAZOL NITRATO	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		1,0094
	ENALAPRILO, MALEATO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**SI**	3,2059
OX	ERGOCALCIFEROL = Calciferol = Vitamina D = Vitamina D2	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		39,8674
X	ERITROMICINA BASE			0,741
X	ESPIRONOLACTONA	(sólo por vía sistémica)	**SI**	2,4768
X	ESTRADIOL 17-BETA		**SI**	23,3107
	ESTREPTOMICINA SULFATO	(como monofármaco)		0,2205
X	ESTRIOL		**SI**	89,1584
X	ESTRONA		**SI**	13,7664
X	ETAMBUTOL CHORHIDRATO		**SI**	0,1379
X	ETINILESTRADIOL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**Si**	29,4912
	FENILALANINA	(sólo vía sistémica) y vía tópica en vitíligo		0,18

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	FENILBUTAZONA	(como monofármaco)		0,1133
	FENITOÍNA = Difenilhidantohína		**SI**	0,3052
	FENOBARBITAL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**SI**	0,2644
X	FITOMENADIONA = Vitamina K	(como monofármaco)	**SI**	13,4131
	FLECAINIDA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**SI**	
X	FLUMETASONA PIVALATO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		67,8144
X	FLUOCINOLONA ACETÓNIDO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		24,9344
X	5-FLUOROURACILO	(sólo por vía tópica)	**SI**	3,744
X	FÓLICO ÁCIDO	(como monofármaco o asociado con sales de hierro)		0,3562
	FOSFATO MONOPOTÁSICO	agentes solventes y diluyentes		0,032
	FOSFATO MONOSÓDICO DIHIDRATADO = Sodio fosfato monobásico dihidratado			0,0209
X	FUROSEMIDA		**SI**	0,3387
	GENTAMICINA SULFATO	(como monofármaco o asociado a corticoides para uso oftálmico)		1,9065

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	GLICEROFOSFATO CALCIO = Calcio glicerofosfato	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,1483
	GLUCONATO CÁLCICO = Calcio gluconato	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0213
	HALCINONIDA	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		44,5102
	HIDRALAZINA CHORHIDRATO		**SI**	1,6742
	HIDROCLOROTIAZIDA		**SI**	0,1594
X	HIDROCORTISONA ACETATO	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		4,3603
X	HIDROCORTISONA BASE	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		4,0538
	HIDROXICINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		1,0846
	HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA	(sólo por vía sistémica)	**SI**	5,7054
X	HIDROXIPROGESTERONA 17-ALFA = Hidroxiprogesterona Hexanoato = Hidroxiprogesterona caproato	(como monofármaco)	**SI**	16,7186
X	HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO = Hidroxiprogesterona 17-Alfa = Hidroxiprogesterona Hexanoato		**SI**	16,7186
X	HIDROXIPROGESTERONA HEXANOATO = Hidroxiprogesterona Caproato = Hidroxiprogesterona 17-Alfa	(sólo por vía sistémica)	**SI**	16,7186

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	HIERRO GLUCONATO	(como monofármaco o asociado a ac. fólico)		0,0534
X	HIERRO OXALATO	(como monofármaco o asociado a ac. fólico)		0,0708
	HIERRO SULFATO (Ferroso)	(como monofármaco o asociado a ac. fólico)		0,0138
	ICTAMOL = Ictiol			0,0778
	ICTIOL = Ictamol			0,0778
X	IDOXURIDINA = Idu			14,1056
X	IDU = Idoxuridina			14,1056
X	IMIPRAMINA CLORHIDRATO		**SI**	0,9316
X	INDOMETACINA	(como monofármaco)		0,1932
OX	IODO METALOIDE	(sólo por vía sistémica)		0,1765
X	IODOCLORHIDROXIQUINOLEÍNA = Clioquinol = Cloroiodoquina	(vía tópica y sólo asociado a otros p.a.)		0,3899
	IPECACUANA EXTRACTO FLUIDO			0,572
	IPECACUANA TINTURA			0,119
X	ISONIAZIDA		**SI**	0,0677
X	ISOTRETINOÍNA = 13 Cis retinoico ácido = Retinoico ácido 13-Cis	(vía oral, ECM, visado de inspección)		36,004

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	KELINA	(vía tópica en concentraciones del 2% al 5%)		2,5942
X	KETOCONAZOL	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		1,1857
	KETOPROFENO	(como monofármaco)		0,8871
	KETOTIFENO FUMARATO	como monofármaco		68,8116
X	LEVAMISOL	(sólo por vía sistémica en dosis iguales o menores a 50 mg)	**SI**	1,1212
X	LEVODOPA		**SI**	0,867
X	LEVOTIROXINA = Tiroxina	(como monofármaco)	**SI**	21,9652
	LIDOCAÍNA BASE = Xilocaína base	(no formulable en antihemorroidales)		0,1251
	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	(no formulable en antihemorroidales)		0,0922
X	LIOTIRONINA = Triodotironina	(como monofármaco)	**SI**	89,5061
	LOPERAMIDA			7,5311
	MAGNESIO CARBONATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0194
O	MAGNESIO CLORURO	(como monofármaco en dosis igual o mayor a 15 gr)		0,0097
	MAGNESIO HIDRÓXIDO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0246
	MAGNESIO OXIDO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0241

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	MAGNESIO SULFATO POLVO	(como monofármaco en dosis igual o mayor a 15 gr)		0,0099
	MAGNESIO TRISILICATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0217
	MEBENDAZOL			1,5967
X	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO	(como monofármaco o asociado con gentamicina y/o tetraciclinas para administración oftálmica)		10,8928
	MENADIONA = Vitamina K3 hidrosoluble	(como monofármaco)	**SI**	0,2463
	MEPROBAMATO			0,2829
	MESALAZINA = 5 Aminosalicílico Ácido = 5 ASA		**SI**	0,3705
X	METADONA CLORHIDRATO			0,8246
	METFORMINA	(como monofármaco)	**SI**	0,087
X	METILPREDNISOLONA 6-ALFA	(como monofármaco. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)	**SI**	22,8764
OX	METILSALICILATO = Salicilato de metilo			0,025
	METILTESTOSTERONA	(sólo por vía sistémica)		9,5617
	METILTIONINA CLORURO = Azul de Metileno	(sólo por vía sistémica)		0,3532
X	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO			0,722

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	METOXALENO = 8 Metoxipsoraleno		**SI**	5,9616
X	METOXIPSORALENO-8 = Metoxaleno		**SI**	5,9616
X	METRONIDAZOL			0,1146
	MICONAZOL NITRATO	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		0,8944
X	MORFINA CLORHIDRATO		**SI**	1,0018
X	NAFAZOLINA CLORHIDRATO	(sólo en asociaciones de uso oftálmico)		1,4195
	NAFTALAN	(solamente asociado a otros antipsoriásicos)		0,0032
X	NALIDÍXICO ÁCIDO	(como monofármaco)		0,4217
	NAPROXENO	(como monofármaco)		0,6374
	NEO HELIOPAN E1000	(en casos de Lupus Eritematoso, visado de Inspección)		0,0997
X	NEOMICINA SULFATO	(como monofármaco)		0,3882
	NEOMICINA UNDECILINATO	(como monofármaco)		0,5443
	NICARDIPINO CLORHIDRATO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**Si**	1,4387
X	NICLOSAMIDA			1,5796
X	NICOTINAMIDA = Vitamina PP	(como monofármaco)		0,0672

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	NICOTINATO DE METILO	(como monofármaco)		0,2015
X	NICOTINICO ÁCIDO			0,0569
	NIFEDIPINA		**SI**	1,1488
X	NISTATINA	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		1,0131
X	NITROGLICERINA	(sólo por vía tópica)		45,6103
X	NORETISTERONA ACETATO	(sólo por vía sistémica)	**SI**	33,6512
X	NORTRIPTILINA		**SI**	5,7272
	OMEPRAZOL PELLETS	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		0.7788
	OXANDROLONA	(con visado de inspección)		77,056
	OXAZEPAM	(como monofármaco)		1,803
	OXIBENZONA	(en casos de Lupus Eritematoso, visado de Inspección)		0,1364
	OXIFENBUTAZONA	(con monofármaco)		0,3802
X	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a corticoides para uso oftálmico)		0,0706
X	P-AMINO SALICÍLICO ÁCIDO = PAS		**Si**	0,0943
X	PAPAVERINA BASE	(como monofármaco)		0,534

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	PAPAVERINA CLORHIDRATO	(como monofármaco)		0,5734
X	PARACETAMOL			0,0467
	PARSOL 1789	(en casos de Lupus Eritematoso, visado de inspección)		0,182
	PARSOL MCX	(en casos de Lupus Eritematoso, visado de inspección)		0,093
X	PAS = P-Amino salicílico		**SI**	0,0943
X	PERMETRINA	(vía tópica en concentraciones iguales o mayores del 5%)		0,4154
X	PILOCARPINA CLORHIDRATO	(sólo para colirios)		14,24
X	PIPERAZINA CITRATO			0,0269
	PIRACETAM			0,078432
X	PIRAZINAMIDA		**SI**	0,3233
X	PIRIDOXINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a isoniazida)		0,2086
X	PIRIDOXINA = Vitamina B6	(como monofármaco)		0,135588
	PIRIMETAMINA	(sólo por vía oral y en concentraciones pediátricas)	**SI**	3,8465
	PIROXICAM	(como monofármaco)		0,3971
	PODOFILOTOXINA			0,4458

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	PODOPHYLLUM PELTATUM RESINA			1,5454
	POTASIO BICARBONATO			0,0081
	POTASIO BITARTRATO			0,0041
	POTASIO CITRATO			0,0143
	POTASIO CLORURO			0,0105
	POTASIO FOSFATO			0,0221
X	POTASIO IODURO	(sólo por vía sistémica)		0,124
	PRAZIQUANTEL	(sólo por vía oral)		0,3629
X	PREDNISOLONA	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		5,1475
X	PREDNISONA	(como monofármaco, o asociado a un queratolítico para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		5,0618
	PROBENECIDA		**SI**	1,4733
X	PROCAÍNA, CLORHIDRATO	(no formulable en antihemorroidales)		0,0811
X	PROGESTERONA	(vía sistémica) (vía tópica como monofármaco en concentraciones iguales o mayores al 10%)	**SI**	1,1066

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	PROMETAZINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		0,304
	PROPAFENONA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	**SI**	1,7189
X	PROPRANOLOL		**SI**	0,1127
	QUINIDINA SULFATO		**SI**	6,0333
	QUINIDINA SULFATO BÁSICO		**SI**	6,0333
X	QUININA CLORHIDRATO	(como antimalárico)	**SI**	0,6573
X	QUININA SALICILATO	(como antimalárico)	**SI**	1,335
X	QUININA SULFATO	(como antimalárico)	**SI**	0,7449
	RANITIDINA			0,4014
X	RESERPINA		**SI**	3,6941
X	RETINOICO ÁCIDO 13-CIS = Isotretinoína = 13-Cis Retinoico Ácido	(vía oral, ECM, visado de Inspección)		36,004
X	RETINOICO ÁCIDO TRANS = Trans Retinoico Ácido = Tretinoína = Vitamina A ácida	(como monofármaco o asociado a un corticoide y/o queratolíticos para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		10,5528
X	RETINOL ACETATO	(como monofármaco o asociado a otros cicatrizantes)		0,2699
X	RETINOL PALMITATO	(como monofármaco o asociado a otros cicatrizantes)		0,3638

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	RETINOL = Vitamina A hidrosoluble	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,1521
X	RIBOFLAVINA = Vitamina B2	(como monofármaco)		0,2578
X	RIFAMPICINA	(sólo por vía sistémica)	**SI**	0,7923
X	SALBUTAMOL SULFATO	(como monofármaco)	**SI**	4,2306
X	SALICILAMIDA			0,0781
OX	SALICILATO METILO = Metilo salicilato			0,0214
	SALICILATO SÓDICO = Sodio salicilato			0,0536
	SALICÍLICO ÁCIDO	(como monofármaco o asociado a un antipsoriásico o a un corticoide y/o queratolíticos y en concentraciones hasta el 10%)		0,019
	SAUCO, FLOR			0,1146
	SODIO BICARBONATO			0,019
	SODIO CITRATO = Citrato sódico			0,0177
	SODIO CROMOGLICATO = Cromoglicato disódico		**SI**	1,7185
	SODIO FLUORURO	(sólo por vía oral y en dosis iguales o superiores a 6 mg)		0,0953
	SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATADO = Fosfato monobásico dihidratado			0,0154

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	SODIO FOSFATO TRIBÁSICO			0,013
	SODIO HIPOSULFITO = Sodio tiosulfato = Tiosulfato sódico			0,0177
X	SODIO SALICILATO = Salicilato Sódico			0,0536
	SODIO TIOSULFATO = Sodio Hiposulfito = Tiosulfato sódico			0,0177
	SODIO, CLORURO	(no formulable en colirios)		0,019
	SUCRALFATO			0,21
X	SULFACETAMIDA SÓDICA	(como monofármaco)		0,0883
X	SULFADIAZINA = Sulfapirimidina	(como monofármaco)		0,1129
X	SULFAMETOXAZOL	(como monofármaco o asociado a Trimetropin)		0,1076
X	SULFAMETOXIPIRIDAZINA	(como monofármaco)		0,1549
X	SULFAPIRIMIDINA = Sulfadiazina	(como monofármaco)		0,1129
	SULISOBENZONA	(en casos de Lupus Eritematoso, visado de Inspección)		0,3031
	SULPIRIDE	(como monofármaco o asociado a ansiolíticos)	**SI**	0,6144
	TARDOAK			0,258
	TEOFILINA ANHIDRA	(como monofármaco)		0,1075

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	TEOFILINA RETARDADA MICRONIZADA	(como monofármaco)		0,2113
X	TEOFILINATO DE COLINA	(como monofármaco)		0,0758
X	TERBUTALINA	(como monofármaco por vía inhalatoria)	**SI**	12,992
X	TESTOSTERONA PROPIONATO		**SI**	2,0054
X	TETRACICLINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a corticoides para uso oftálmico)		0,1619
	TIABENDAZOL			0,3199
X	TIAMINA CLORHIDRATO = Vitamina B1 Chorhidrato	(como monofármaco)		0,2005
X	TIAMINA MONONITRATO = Vitamina B1 Mononitrato	(como monofármaco)		0,2005
	TIOSULFATO SÓDICO = Sodio Hiposulfito = Sodio tiosulfato			0,0177
X	TIROXINA = Levotiroxina	(como monofármaco)	**SI**	17,7631
	TOCOFEROL ACETATO = Vitamina E acetato	(como monofármaco)		0,191
X	TOCOFEROL SUCCINATO = Vitamina E succinato	(como monofármaco)		0,4093
	TOCOFEROL = Vitamina E oleosa	(como monofármaco)		0,1416
	TOLNAFTATO	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		1,4611

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	TRANS RETINOICO ÁCIDO = Retinoico ácido trans = Tretinoína = Vitamina A ácida	(como monofármaco o asociado a un corticoide y/o queratolíticos para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		10,5528
X	TRETINOíNA = Trans Retinoico ácido = Retinoico ácido trans = Vitamina A ácida	(como monofármaco o asociado a un corticoide y/o queratolíticos para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		10,5528
	TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftámica)		8,8986
	TRIAMCINOLONA BASE	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftámica)		23,8336
X	TRIAMTERENO		**SI**	0,4902
X	TRIIODOTIRONINA = Liotironina	(como monofármaco)	**Si**	93,0944
X	TRIMETILPSORALENO = Trioxaleno = Trioxisaleno		**SI**	18,5792
	TRIMETOPRIM	(como monofármaco o asociado a sulfametoxazol)		0,1916
X	TRIOXALEN = Trioxaleno = Trioxisaleno		**SI**	18,8288
X	TRIOXALENO = Trimetilpsoraleno = Trioxisalen		**SI**	18,8288
X	TRIOXISALENO=Timetilpsoraleno=Trioxalen		**SI**	18,8288

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
	TRIPOTASIO DICITRATO BISMUTO = Bismuto Subcitrato = Bismuto dicitrato tripotasio.	(como monofármaco)		2,2554
	TRIPSINA			8,1557
	TROMETAMOL			0,0978
	TUMENOL			0,0925
X	UNDECILÉNICO, ÁCIDO			0,0954
	VERAPAMILO		**SI**	1,1001
	VINCAMINA			8,5376
X	VITAMINA A ACETATO = Retinol acetato	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,2699
X	VITAMINA A ÁCIDA = Tretinoína = Retinoico ácido trans = Trans Retinoico ácido	(como monofármaco o asociado a un corticoide para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		10,5528
X	VITAMINA A HIDROSOLUBLE = Retinol	(como monofármaco)		0,2291
X	VITAMINA B1 = Tiamina	(como monofármaco)		0,2005
X	VITAMINA B12 = Cianocobalamina	(como monofármaco)		25,9161
X	VITAMINA B2 = Riboflavina	(como monofármaco)		0,2578
X	VITAMINA B6 = Piridoxina	(como monofármaco)		0,2329

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Euros/g ó ml
X	VITAMINA C = Ascórbico ácido	(como monofármaco sólo por vía parenteral)		0,0399
OX	VITAMINA D = Calciferol = Ergocalciferol = Vitamina D2	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		39,8684
OX	VITAMINA D2 = Calciferol = Ergocalciferol = Vitamina D	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		39,8684
OX	VITAMINA D3 = Colecalciferol	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		13,6064
	VITAMINA E ACETATO = Tocoferol acetato	(como monofármaco)		0,191
X	VITAMINA E OLEOSA = Tocoferol	(como monofármaco)		0,1407
X	VITAMINA E SUCCINATO = Tocoferol succinato	(como monofármaco)		0,4093
X	VITAMINA H = Biotina	(como monofármaco)		15,2333
X	VITAMINA K3 HIDROSOLUBLE = Menadiona	(como monofármaco)		0,1146
X	VITAMINA PP = Nicotinamida	(como monofármaco)		0,0672
	ZINC ACETATO			0,0286
	ZINC GLUCONATO	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,1075
	ZINC SULFATO DIFFUCAPS	(vía sistémica como monofármaco)		0,4488
	ZINC SULFATO POLVO	(vía sistémica como monofármaco y vía tópica)		0,0304
	ZINC SULFATO	(vía sistémica como monofármaco o vía tópica)		0,0252

TABLA II: LISTADO DE EXCIPIENTES

Excipientes	Euros
- SOLUCIONES Y SUSPENSIONES ESTÉRILES	0,32 € / 10 ml
- SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES EXCEPTO JARABES Acuosas Hidroalcohólicas y otras no acuosas	 0,59 € / 100 ml ó fracción 2,00 € / 100 ml ó fracción
- JARABES	1,86 € / 100 ml ó fracción
- PASTAS Y POMADAS ANHIDRAS	1,33 € / 100 ml ó fracción
- EMULSIONES, GELES Y COLODIONES	1,86 € / 100 ml ó fracción
- POLVOS Y GRANULADOS	0,66 € / 100 ml ó fracción
- SUPOSITORIOS, ÓVULOS Y BARRAS LABIALES	0,13 € / unidad
- CÁPSULAS ENTÉRICAS	0.03 € / unidad

TABLA III: HONORARIOS PROFESIONALES

FORMA FARMACÉUTICA	Máximo	
Inyectables (soluciones, suspensiones)	25	P x 11
Colirios y pomadas oftálmicas	1	P x 11
Óvulos y supositorios	25	P x 5
Papeles y sellos	50	P x 6
Cápsulas	100	P x 9

FORMA FARMACÉUTICA	*Gramos ò Mililitros*	
	Máximo	
Pastas y pomadas anhidras	250	P x 5
Granulados, emulsiones y geles	250	P x 6
Polvos compuestos	250	P x 4
Suspensiones	250	P x 5
Soluciones estériles	1000	P x 8
Soluciones y enemas*	1000	P x 5

* El volumen total máximo será de 1.000 ml pudiendo ir distribuidos en varios envases (ej. enemas de 100 ml podrán ir en una receta hasta 10 enemas, que se tasarán sobre 1.000 ml).

TABLA IV: PRECIO DE LOS ENVASES

FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS	Euros
Frasco plástico blanco opaco tapón precinto 50 cc	0,354
Frasco plástico blanco opaco tapón precinto 125 cc	0,609
Frasco plástico blanco opaco tapón precinto 250 cc	0,631
Frasco plástico blanco opaco tapón precinto 500 cc	0,708
Frasco plástico blanco opaco tapón precinto 1000 cc	0,897
Frasco plástico topacio tapón precinto 30 cc	0,443
Frasco plástico topacio tapón precinto 60 cc	0,642
Frasco plástico topacio tapón precinto 125 cc	0,697
Frasco plástico topacio tapón precinto 250 cc y superiores	0,719
Frasco cristal topacio tapón precinto 30 cc	0,354
Frasco cristal topacio tapón precinto 60 cc	0,398
Frasco cristal topacio tapón precinto 125 cc	0,420
Frasco cristal topacio tapón precinto 250 cc	0,564
Frasco cristal topacio tapón precinto 1000 cc	1,810
Frasco cristal topacio cuentagotas 30 cc	0,430
Frasco cristal topacio cuentagotas 60 cc	0,486
Frasco cristal topacio cuentagotas 125 cc	0,610
FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS	**Euros**
Envase de 20 cc	0,443
Envase de 30 cc	0,941
Envase de 50 cc	1,052
Envase de 100 cc	1,384
Envase de 200 cc y superiores	1,838
CÁPSULAS – PAPELES	**Euros**
Envase de hasta 50 unidades	0,531
Envase de hasta 100 unidades	0,542
INYECTABLES	**Euros**
Envase	0,398
COLIRIOS	**Euros**
Frasco estéril	0,664

Los envases de plástico topacio se utilizarán para las fórmulas fotosensibles en general (fórmulas en las que intervengan productos señalados con "X"). Los envases de cristal topacio se utilizarán para las fórmulas en las que intervengan productos señalados con "OX y O"

ANEXO C.
Procedimiento de facturación y pago

La facturación de recetas a cargo del Servicio Cántabro de Salud se realizará según el procedimiento indicado en este Anexo y se efectuará a través del procesamiento informático de las mismas. Para facilitar su mecanización, el Servicio Cántabro de Salud procurará que las recetas mantengan las mismas características de dimensión y gramaje.

El coste de la facturación y digitalización de las recetas será asumido íntegramente por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria; cualquier nuevo supuesto podrá ser concertado.

A fin de poder asignar los precios correctamente, la Administración Sanitaria facilitará a la Corporación Farmacéutica el Nomenclátor Oficial de Productos Farmacéuticos. Además el Servicio Cántabro de Salud entregará al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, tanto el Vademécum de Principios Activos como el Listado-Nomenclátor de dietas aplicables en el proceso de facturación.

1. NORMAS PREVIAS A LA FACTURACIÓN

Las Oficinas de Farmacia procederán de la siguiente forma una vez efectuada la dispensación:

1.1. Consignarán en la receta el sello de la farmacia con el nombre y número de la farmacia, la fecha de dispensación y firma del farmacéutico. Si se trata de una receta modelo T.L.D, además sellarán y fecharán en el recuadro previsto a tal efecto, en el reverso del o de los cuerpos de la receta de las siguientes dispensaciones.

1.2. Colocarán en el lugar reservado al efecto el cupón o cupones-precinto de los medicamentos, de los efectos y accesorios que lo tengan, y la etiqueta con el código nacional de los productos dietoterápicos complejos y de nutrición enteral domiciliaria.

En el caso de que el producto a dispensar no lleve cupón-precinto se colocará junto con el comprobante de dispensación, salvo que exista imposibilidad material, una etiqueta autoadhesiva o se estampillará un sello, según recoge el Anexo I para distinguir los siguientes casos de dispensación :

CÓDIGO	
500009	VACUNAS INDIVIDUALIZADAS (antialérgicas y bacterianas)
500017	FÓRMULAS MAGISTRALES DE APORTACIÓN NORMAL
500033	OTROS VISADOS (tiras reactivas)
500041	VISADOS SIN CUPÓN PRECINTO (medias compresión normal)
500058	FÓRMULAS MAGISTRALES DE APORTACIÓN REDUCIDA

En dicha etiqueta autoadhesiva o sello se consignará obligatoriamente y de forma legible el precio de facturación del producto dispensado.

Tanto el cupón-precinto como la etiqueta autoadhesiva o el sello, se colocarán de forma que se procure su legibilidad y su no desprendimiento en la manipulación normal o durante el procesamiento informático.

2. PROCESO DE FACTURACIÓN

El proceso de toma de datos, grabación y facturación se realizará por el Colegio Oficial de Farmacéuticos por medios propios o concertados con empresas externas debidamente acreditadas y certificadas por los correspondientes organismos oficiales.

2.1. Toma de datos

Los datos a grabar a partir de las recetas y que son considerados necesarios para el proceso de facturación y un correcto control de la prestación farmacéutica son los siguientes:

1. Provincia: *2 dígitos*
2. Mes: 2 *dígitos*
3. Año: 4 *dígitos*
4. Número de farmacia: *4 dígitos*
5. Número de paquete: *4 dígitos*
6. Número de receta en el paquete: 2 *dígitos*
7. Grupo de facturación: *1 dígito*
8. Régimen de receta: *1 dígito*
9. Tipo de receta: *1 dígito*
10. Tipo de dispensación: *1 dígito*
11. Código Nacional del medicamento, efecto o accesorio, Código identificativo oficial de los productos dietoterápicos complejos y de nutrición enteral domiciliaria, o Código de la etiqueta autoadhesiva del sello en su caso: *7 dígitos*
12. Precio facturación: *9 dígitos*
13. Líquido facturado: *9 dígitos*
14. Número de envases: *1 dígito*
15. Número de colegiado médico: 12 dígitos
16. Clave de Identificación de Asistencia Sanitaria del médico CIAS (o CPF): *11dígitos*
17. Número de la receta: *12 dígitos* (talonario 10 + receta 2)
18. Código de Identificación del Paciente (CIP): *16 dígitos*
19. Fecha de prescripción C.B. PDF-417, formato AAAAMMDD*: 8 dígitos*
20. Código Nacional del producto farmacéutico prescrito en C.B. PDF-417 o código de barras cuando éste haya sido prescrito informáticamente por el médico: *6 dígitos*

En el caso de que las recetas no lleven impreso el código de barras bi-dimensional PDF-417, por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos se procederá a grabar todos los datos indicados anteriormente, excepto el CIP (punto 18), el localizador de receta (punto 19) y la fecha de prescripción (punto 20).

En el caso de que el producto farmacéutico no tenga precio acordado por ambas partes o no tenga precio en el Nomenclátor Oficial del Ministerio de Sanidad, o bien no se pueda leer informáticamente, no se tomará este dato, pero se adoptarán las medidas necesarias que no supongan un perjuicio económico para ninguna de las partes.

El conjunto de todos los datos citados, tomados y grabados por el Colegio de Farmacéuticos, estará dirigido al Servicio Cántabro de Salud para el conocimiento de la facturación y el control de la prestación a través de las Oficinas de Farmacia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos, por su parte, podrá usar únicamente a efectos de facturación el mismo conjunto de datos, a excepción del número de colegiado del médico, la Clave de Identificación de Asistencia Sanitaria CIAS o CPF y el Código de Identificación del

Paciente CIP, por lo que estos tres datos se abstendrán de tomarlos y grabarlos para sí, ya que serán de utilización exclusiva por el Servicio Cántabro de Salud.

En todo caso el proceso de digitalización que asume el Colegio Oficial de Farmacéuticos asegurará que las imágenes digitalizadas y facturadas son legibles y fiel reproducción de los originales. En el supuesto de que, una vez finalizado el proceso de digitalización de las recetas, ocurriese algún accidente o robo y las recetas de papel fueran irrecuperables, las imágenes obtenidas tendrán los efectos de copias auténticas a las recetas de papel y por tanto, el Servicio Cántabro de Salud abonará el importe íntegro de la factura presentada por el Colegio elaborada con la información obtenida de la digitalización.

2.2. Confección de los soportes informáticos de facturación

La grabación de los datos de facturación se realizará en CD-ROM en fichero único para toda la facturación. Este debe ser un fichero secuencial en formato ASCII con un número de orden único para cada receta y tendrá tres tipos de registros:

a) Registro de cabecera, único y situado al principio del fichero, con la siguiente estructura:

- Código de la provincia *2 dígitos*
- Año de los datos *4 dígitos*
- Mes de facturación *2 dígitos*
- Fecha de generación del fichero (dd/mm/aaaa) *10 dígitos*

b) Registros de datos de las recetas: contiene la información de cada una de las recetas.

c) Registro final, único y situado al final del fichero, con la siguiente estructura:

- Código de la provincia *2 dígitos*
- Año de los datos *4 dígitos*
- Mes de los datos *2 dígitos*
- Fecha de generación del fichero (ddl/mm/aaaa) *10 dígitos*
- Número de recetas registradas en el fichero *9 dígitos*
- Importe total de las recetas registradas (PVP) *14 dígitos*

No se utilizarán delimitadores, estando ubicados cada uno de los datos que componen el registro en una dirección determinada y fija.

El CD-ROM irá identificado externamente con una etiqueta donde conste el mes y el Servicio de Salud al que corresponde la facturación y el número de registros que contiene.

El CD-ROM se acompañará de un Disco USB conteniendo las imágenes digitalizadas del anverso de todas las recetas facturadas ese mes, asociadas al CD-ROM de datos mediante un visor de recetas que facilitará la selección de las mismas en sistema access.

A efectos de facturación se codificarán los diferentes **grupos de facturación** de la siguiente forma:

1. Medicamentos
2. Efectos y Accesorios
3. Fórmulas magistrales y varios

Cada uno de los grupos referidos anteriormente irá separado en los siguientes **regímenes**:

1. Trabajadores activos
2. Trabajadores Pensionistas
3. Accidentes de trabajo
4. Síndrome Tóxico
5. Minusválidos
6. Campañas sanitarias
7. Otros

La codificación del **tipo de receta** se realizará de acuerdo con:

1. Receta ordinaria sin visado
2. Receta ordinaria con visado
3. Receta T.L.D.
4. Receta prescripción por principio activo.
5. Receta prescripción principio activo desabastecimiento.
6. Productos dietoterápicos.

La codificación del **tipo de dispensación** se realizará de acuerdo con:

1. Receta en papel
2. Receta electrónica

2.3. Periodo de facturación

La facturación comprenderá periodos mensuales y contendrá las recetas dispensadas en el mes considerado. El Colegio Oficial de Farmacéuticos velará para que los plazos de cierre de la facturación se ajusten al último día del mes, garantizando el cierre conjunto para todas las modalidades de dispensación.

2.4. Confección de facturas

Con la información obtenida de las recetas, además de grabarla en CD-ROM, que se utilizará como instrumento de control de proceso, el Colegio Oficial de Farmacéuticos confeccionará mensualmente la factura de recetas que servirá como documento para la formalización del pago.

Se confeccionarán tres clases de facturas:

- Factura individual por farmacia -Anexo II.
- Factura resumen por grupo de facturación y tipo de receta - Anexo III .
- Factura resumen general - Anexo IV.

2.4.1. Factura individual por farmacia - Anexo II

Se confeccionarán facturas individuales de cada farmacia en soporte informático CD-ROM y formato PDF clasificando por separado para cada uno de los siguientes tipos de receta y grupo de facturación:

1. Medicamentos en receta ordinaria sin visado
2. Medicamentos con visado (incluidas T.L.D).
3. Medicamentos en receta T.L.D sin visado
4. Medicamentos con prescripción por principio activo
5. Medicamentos con prescripción por principio activo desabastecimiento
6. Efectos y accesorios sin visado.

7. Efectos y accesorios con visado (Absorbentes incontinencia de orina)
8. Fórmulas magistrales y varios (recetas con etiqueta autoadhesiva o sello).
9. Productos dietoterápicos.
10. Otros.

Y dentro de cada tipo de receta y grupo, por separado por cada régimen:

1. Trabajadores activos .
2. Trabajadores Pensionistas.
3. Accidentes de trabajo.
4. Síndrome Tóxico.
5. Minusválidos.
6. Campañas sanitarias
7. Otros

Las recetas de medicamentos con visado de Inspección, dispensados en receta Ordinaria y T.L.D, se facturarán en el 2.

Las recetas con prescripción por principio activo con visado de Inspección se facturarán en el 4.

En el 8 se incluirán, tanto las recetas de fórmulas magistrales, como de vacunas individualizadas antialérgicas y otros productos sin cupón-precinto y etiqueta-autoadhesiva o sello.

En las facturas individuales por farmacias (Anexo II), se relacionarán todas las recetas, consignando el código nacional del cupón-precinto o el código de la etiqueta autoadhesiva o sello, en su caso, y el importe del precio de facturación, así como las sumas por cada dos paquetes de veinticinco recetas. El número de paquete será incluido en la factura, anteponiéndose al listado de la serie de recetas que comprenda aquél.

Se señalarán los medicamentos y efectos y accesorios de aportación reducida a las que se refiere la normativa vigente con un asterisco impreso en la posición anterior a la primera cifra de la clave del producto.

Al final de cada factura individual se consignará el número de recetas facturadas, su importe a PVP de facturación, la suma de las aportaciones y el líquido resultante.

2.4.2. Factura resumen por grupo de facturación y tipo de receta - Anexo III

Se confeccionará en soporte informático CD-ROM y formato PDF una factura resumen por cada grupo de facturación, régimen y tipo de receta que recogerá los totales de todas las facturas individuales, por farmacia.

2.4.3. Factura resumen general - Anexo IV

Con los totales de las facturas resumen de cada grupo de facturación, régimen y tipo de receta, se confeccionará una factura general en papel, detallando el número de recetas, precio de facturación, aportación general y líquido facturado de todas las recetas, así como el total del descuento aplicable según la normativa vigente en materia de márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano y el descuento de Absorbentes de Incontinencia de Orina calculados.

3. PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN

3.1. Presentación de las facturas

Las facturas resumen (Anexo IV) en el soporte indicado anteriormente se presentarán por el Colegio Oficial de Farmacéuticos en la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud el día 10 del mes siguiente al que corresponde la facturación. Si el día 10 fuera inhábil, se entenderá como día de entrega el anterior día hábil.

Solamente, en casos excepcionales y plenamente justificados, se admitirán retrasos en su presentación que, lógicamente podrían trascender en igual medida a su pago.

3.2. Presentación de los soportes informáticos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos entregará, en la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, el CD ROM con la correspondiente facturación mensual, conjuntamente con el Disco USB de digitalización de las imágenes y el soporte informático del Anexo II y Anexo III a partir del día 10 del mes siguiente al que corresponda la facturación y hasta el día 20 del mismo. Si el día 20 fuera inhábil se entenderá como día de entrega el siguiente día hábil.

La imagen grabada debe tener una calidad mínima que facilite su visionado y utilización por parte del Servicio Cántabro de Salud (formato JPG).

Excepcionalmente, durante un plazo transitorio de un mes desde la entrada en vigor del Concierto, si el Colegio Oficial de Farmacéuticos por causa justificada tuviera problemas en relación con la grabación de los nuevos datos a tomar de las recetas se admitirá una demora de una máximo de 10 días en el plazo de presentación de los CD ROM y disco USB.

3.3. Devolución de los soportes informáticos

El Servicio Cántabro de Salud analizará la información contenida en los CD ROM y disco USB, y devolverá los que tengan deficiencias técnicas que impidan su tratamiento informático o una explotación completa de la información, así como los que presenten diferencias con el total de la factura resumen (Total PVP y Líquido) superiores al 0,7 por diez mil.

La devolución de los soportes informáticos incorrectos recibidos hasta el día 20 se efectuará hasta el día 30 del mismo mes. Los CD ROM o disco USB corregidos, y si procediera nueva factura, se entregará por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos antes del día 5 del mes siguiente. Si se produjeran nuevas devoluciones, los soportes informáticos deberán ser presentados correctamente y siempre antes del día fijado para la presentación de las recetas.

Si se comprobara en el análisis interno de la facturación mediante la Aplicación Informática para la Gestión de la Prestación Farmacéutica la falta de concordancia entre los datos de facturación grabados en los soportes informáticos y los que consten en las correspondientes recetas, debidos a errores de digitalización, se notificará a la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica que acordará, en caso de que el indicador de calidad de grabación superase el 4% de errores, devolver los mencionados soportes informáticos para subsanar los errores detectados, acompañándose de las correspondientes recetas. No se considerará error de grabación cuando sea materialmente imposible leer la información o la receta sea ilegible,

3.4. Reciclaje de los soportes informáticos.

Los discos USB serán devueltos por el Servicio Cántabro de Salud al Colegio Oficial de Farmacéuticos para su reutilización en un plazo máximo de cuatro meses desde su recepción. Estos discos serán devueltos en perfecto estado y sin contener ninguna imagen o dato anterior.

3.5. Presentación de las recetas.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos presentará las recetas originales antes de finalizar el mes siguiente al que corresponda la presentación de la factura. No obstante y por motivos justificados, podrán ser entregadas en los primeros días del mes siguiente.-

La presentación de recetas se efectuará en la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, en la que se verificará, en presencia de la representación del Colegio que la documentación recibida es la facturada, levantando la Sección de Farmacia acta de la recepción, en la que constará la documentación recibida y el resultado de la verificación conforme al modelo Anexo VIII.

Se presentarán por separado en cajas siguiendo los diferentes grupos:

1. Medicamentos sin visado en receta ordinaria de trabajadores activos, pensionistas.
2. Medicamentos sin visado en receta T.L.D de activos y pensionistas.
3. Medicamentos con visado de activos y pensionistas.
4. Medicamentos con prescripción por principio activo de activos y pensionistas.
5. Medicamentos con prescripción por principio activo desabastecimiento de activos y pensionistas.
6. Efectos y accesorios sin visado de activos y pensionistas
7. Absorbentes de incontinencia de orina de activos y pensionistas
8. Fórmulas y recetas con etiqueta autoadhesiva o sello de activos y pensionistas.
9. Productos dietoterápicos.
10. Otros grupos: accidentes de trabajo, asistencia sanitaria (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero), síndrome tóxico, minusválidos, campañas sanitarias y otros.

Todas las cajas deberán estar especialmente acondicionadas para contener de 500 a 1.000 recetas, unidas por grupos de 25 y de forma que no puedan desordenarse en relación con el Anexo II de la factura.

Las cajas de recetas ordinarias de medicamentos sin visado se presentarán por separado para cada Oficina de Farmacia y régimen de trabajadores activos y pensionistas. Éstas llevarán adherida el siguiente modelo de etiqueta indicando en un formato de letra perfectamente legible el tipo de receta, régimen, mes y nº de farmacia que contiene:

Modelo 1.-

COF CANTABRIA	
GRUPO*	
RÉGIMEN*	MES
FARMACIA Nº:	
CAJA Nº -------- DE UN TOTAL DE -------- CAJAS	

PAQUETES DEL Nº ---------- AL Nº ----------

Grupo: Medicamentos
Régimen: Activo, Pensionista.
Tamaño: 15 x 8 cm

Las cajas del resto de recetas se presentarán conjuntamente las de todas las Oficinas de Farmacia de Cantabria, ordenadas correlativamente por su grupo y después por número de farmacia y por régimen, con el siguiente modelo de etiqueta:-

Modelo 2.-

COF CANTABRIA
GRUPO*
MES:
FARMACIA de la Nº: ---------- a la Nº ---------
CAJA Nº -------- DE UN TOTAL DE -------- CAJAS

Tamaño: 15 x 8 cm

Grupo: T.L.D, Medicamentos con visado, Principio Activo, Principio activo-desabastecimiento, Efectos-accesorios, Absorbentes de Incontinencia de Orina (A.I.O.), Fórmulas-etiqueta autoadhesiva o sello, Dietoterápicos, Accidentes, Síndrome tóxico, Minusválidos, Campañas y otros.

Una vez puesta en marcha la digitalización de las recetas, la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica, podrá modificar la forma de presentación de las recetas hacia una simplificación en la presentación de recetas.

4. REVISIÓN DE LA FACTURACIÓN

4.1. Revisión de los soportes informáticos

El importe correspondiente a las dispensaciones de productos no incluidos en Nomenclátor, o a precio distinto al que figure en el Nomenclátor Oficial de Productos Farmacéuticos, una vez realizadas las comprobaciones informáticas pertinentes, se ajustará en la facturación correspondiente al mes siguiente, adjuntando, en todo caso, la tabla de validación del Servicio Cántabro de Salud con la información necesaria.

Cuando las discordancias se produzcan por diferencia en la aportación a la legalmente establecida, podrá procederse al ajuste de las cantidades indebidamente facturadas, de igual forma que la establecida para los productos no incluidos en Nomenclátor.

4.2. Revisión de recetas.

El Servicio Cántabro de Salud comprobará la facturación presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Las diferencias por las causas de nulidad tipificadas en este Concierto que puedan surgir como resultado de esta comprobación se determinarán a nivel de Oficina de Farmacia y se comunicarán al Colegio dentro de los cuatro meses siguientes a la ultimación de la entrega de recetas y de los soportes informáticos.

Excepcionalmente, se podrá prolongar dicho período, previo Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos dispondrá del mismo período de tiempo para poner en conocimiento del Servicio Cántabro de Salud posibles errores detectados en la facturación.

4.3. Procedimiento de devolución

En el procedimiento de devolución se considerarán válidas a todos los efectos las copias obtenidas del archivo de imágenes digitalizadas de recetas facilitado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Para ello la receta del Servicio Cántabro de Salud dispone en el anverso de un espacio para reseñar las posibles diligencias del farmacéutico.

Los originales de las recetas quedarán en poder del Servicio Cántabro de Salud, no obstante en casos puntuales, el Colegio Oficial de Farmacéuticos podrá solicitar, previo aviso, la vista de los originales; así como la copia del reverso de aquellas recetas en las que sea necesario comprobar algún dato que figure necesariamente al dorso de las mismas o bien de aquellas recetas en las que el espacio para diligenciar el farmacéutico se encuentra en el reverso

A efectos de devolución, se diferenciarán las recetas incursas en causa de nulidad absoluta, nulidad parcial, nulidad de margen profesional, recetas subsanables y errores de facturación, conforme al punto 4.2 del Anexo A del presente Concierto.

4.3.1. Nulidad absoluta.

Las copias de las recetas digitalizadas incursas en causa de nulidad absoluta, se enviarán al Colegio selladas con la leyenda “NULA”.

4.3.2. Nulidad del margen de beneficio profesional.

La copia de las recetas digitalizadas incursas en causa de nulidad parcial, se enviarán al Colegio selladas con la leyenda “NULA MARGEN”.

A las recetas de medicamentos a las que corresponda este tipo de devolución se les descontará, del PVP facturado según el Nomenclátor Oficial, el margen de beneficio profesional legalmente establecido para las dispensaciones al público de medicamentos de uso humano.

Para las recetas afectadas por este tipo de devolución de productos para los que no se encuentra regulado oficialmente el margen de dispensación como efectos y accesorios y vacunas antialérgicas, se acuerda por ambas partes un descuento del 20% sobre el PVP de facturación con objeto de simplificar el procedimiento. Si en alguno de estos casos la Oficina de Farmacia pudiera acreditar que su beneficio bruto profesional había sido menor, podrá reclamar la diferencia.

En el caso de devolución de recetas de Productos Dietoterápicos el descuento del margen será del 15% del PMF, y en las Fórmulas Magistrales se descontará la parte correspondiente a los honorarios profesionales que se fijan en el Anexo B

4.3.3. Nulidad parcial

La copia de las recetas digitalizadas incursas en causa de nulidad parcial, se enviarán al Colegio selladas con la leyenda “NULA PARCIAL”.

4.3.4. Recetas subsanables.

En las recetas incursas en causas de devolución subsanables y que, por tanto, puedan ser recuperables, se procederá de la siguiente forma:

Se descontará de la factura el líquido correspondiente a las recetas incursas en causas de devolución subsanables, y se entregarán los originales al Colegio Oficial de Farmacéuticos con el sello "NULA PROVISIONAL", tanto en la receta como en el cupón-precinto, sello y comprobante de dispensación.

Todas las recetas devueltas por causas subsanables, serán nuevamente entregadas en el Servicio Cántabro de Salud acompañadas de la copia del Anexo V remitido a la Oficina de Farmacia, inexcusablemente, para su comprobación, en el plazo máximo de 60 días, a partir de la fecha de la devolución de las recetas al Colegio, con independencia de que haya podido ser subsanada la causa que motivó la devolución.

Las recetas con la incidencia subsanada, y una vez verificadas las mismas, se abonarán en la siguiente factura, quedando en poder del Servicio Cántabro de Salud los originales de las recetas. No se grabará de nuevo ninguna receta subsanable.

4.3.5. Errores de facturación.

Cuando se produzca una incidencia originada por errores de facturación, ya sea de diferencias de precio, como de recetas facturadas inexistentes o de recetas existentes no facturadas, tanto el Servicio Cántabro de Salud como el Colegio Oficial de Farmacéuticos, se comunicarán el resultado de sus investigaciones, pudiendo éste último solicitar cualquier comprobación complementaria de las recetas originales en la forma y plazos que se establecen para la tramitación del resto de las diferencias detectadas.

4.4. Tramitación de las diferencias detectadas

El Servicio Cántabro de Salud comunicará las diferencias observadas al Colegio Oficial de Farmacéuticos, remitiéndole los modelos de los Anexos V y VI debidamente cumplimentados con la causa de devolución junto con las copias de las recetas digitalizadas incursas en causa de nulidad y los originales de las recetas subsanables.

En el Anexo IX se identifican y codifican las causas de las diferencias detectadas.

En las devoluciones que se practiquen se considerarán los descuentos que hayan sido aplicados por la Administración, conforme a la cláusula número 8 del Concierto.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos podrá objetar las diferencias detectadas en el plazo máximo de 18 días a partir de su conocimiento, para lo cual designará los representantes que estimen oportunos a fin de que, en unión de los correspondientes del Servicio Cántabro de Salud, efectúen la comprobación de las facturas y recetas de la Oficina de Farmacia afectada, en el plazo máximo de diez días contados desde la presentación de tales objeciones.

Una vez transcurrido el plazo fijado, el Servicio Cántabro de Salud procederá a abonar o deducir de la próxima facturación que se presente al cobro, el importe correspondiente a las diferencias no objetadas. En las que existan discrepancias, se someterán a informe de la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica, que habrá de dictaminar en el plazo máximo de dos meses desde la comunicación de las mismas a la Comisión. (Anexo VII)

Si transcurrido el plazo no hubiera acuerdo entre las representaciones, se procederá a descontar las cantidades en litigio de la siguiente facturación, independientemente de que se eleve la discrepancia a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud que emitirá su informe en el plazo de seis meses desde su recepción en la Secretaria de esta Comisión. En caso de sobrepasar este plazo, se abonarán los intereses legales del Banco de España cuando la resolución resulte favorable al farmacéutico, computados desde la fecha de retención de su importe.

Cuando el criterio defendido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos fuera aceptado en todo o en parte por la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Salud procederá a abonar las recetas en litigio en la siguiente facturación con los intereses correspondientes, si procede, según lo especificado en el párrafo anterior.

El Servicio Cántabro de Salud conservará las recetas, ordenadas por farmacias, para efectuar las oportunas comprobaciones al menos durante el plazo fijado en el punto 4.2.

En cuanto a las recetas originales objeto de litigio o de reclamación por haber sido apreciadas en ellas diferencias, serán conservadas por el Servicio Cántabro de Salud hasta que se resuelva lo que corresponda.

La Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica remitirá los originales de las recetas en litigio que deban ser estudiadas por la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, salvo en aquellos casos en que se trate de un número excesivo de recetas, en los que será suficiente remitir una muestra representativa de las mismas.

5. PROCEDIMIENTO DE PAGO

5.1. Una vez presentadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos la factura que figura en el Anexo IV, conforme a los plazos y modelos establecidos en el punto 3.1. de este Anexo C de Facturación, el Servicio Cántabro de Salud informará al Colegio Oficial de Farmacéuticos de los distintos conceptos a abonar, así como del importe líquido resultante.

En dichos conceptos figurará, además del total líquido de la factura mensual (Anexo IV), los descuentos derivados de la normativa vigente en materia de márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano y de los Absorbentes de Incontinencia de Orina, el importe total resultante de la revisión de recetas y el importe de la revisión de los soportes informáticos, incluidas las aportaciones de los beneficiarios del Síndrome tóxico, cuyo pago será efectuado posteriormente a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

5.2. La Dirección General de Tesorería, Presupuesto y Política Financiera del Gobierno del Gobierno de Cantabria cursará órdenes de transferencia, antes del día 20 de cada mes, para que se realice el abono efectivo el día 20 de cada mes al Colegio Oficial de Farmacéuticos, en la cuenta que previamente hubieran señalado éstos, siempre que se hayan recibido en tiempo y forma y resulten validados los correspondientes documentos presupuestarios. Si el día 20 fuera inhábil, se entenderá como fecha valor la del primer día hábil siguiente al día 20.

5.3. El pago de las facturas queda condicionado a la entrega de las recetas al Servicio Cántabro de Salud y los soportes informáticos, conforme a lo establecido en el punto 3 de este Anexo C.

Si no se presentan los soportes informáticos en los plazos establecidos, la fecha de pago del mes siguiente se retrasará en la misma medida.

Los soportes informáticos tienen la consideración de elemento técnico equivalente a la factura individual de cada Oficina de Farmacia (Anexo II) e imprescindible para la comprobación de las facturas resumen (Anexos III y IV) entregadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.

5.4. El pago de la factura resumen a que se refieren los apartados anteriores, se entenderá realizado como "liquidación provisional", estando, por tanto, a resultas de los informes que se obtengan del tratamiento y comprobación de la calidad de la información, en la forma y condiciones dispuestas en el punto 8 del presente Concierto, así como de la entrega de las recetas al Servicio Cántabro de Salud.

5.5. En el caso de que los soportes informáticos y/o facturas resumen sean devueltos por resultar con defectos técnicos o no validados entre sí, deberán ser reenviados en los plazos establecidos en el punto 3.3 del presente Anexo. En caso contrario, la fecha de pago del mes siguiente se pospondrá un mes y siempre que para dicha fecha se encuentren debidamente corregidos y validados.

ANEXO I
MODELO ETIQUETA AUTOADHESIVA O SELLOS

34 mm

VACUNAS INDIVIDUALIZADAS 500009 PVP.....

25 mm

FÓRMULAS MAGISTRALES APORTACIÓN NORMAL 500017 PVP.....

OTROS VISADOS 500033 PVP.....

VISADOS SIN CUPON PRECINTO 500041 PVP.....

FÓRMULAS MAGISTRALES APORTAC. REDUCIDA 500058 PVP.....

ANEXO II
FACTURA INDIVIDUAL POR FARMACIA

FACTURA DE:
Régimen (1)
Grupo de facturación y Tipo de receta (2)

Farmacia número:
D.
Fecha:

Recetas	Código Nacional	Núm. envases	P.V.P.	Aportación	Líquido
Suma P.V.P.					

RESUMEN: **Importe a P.V.P.:**

Aportación del trabajador:
Líquido a percibir:
Número total de recetas:

---

(1)Trabajadores activos, Pensionistas, Accidentes de trabajo, Síndrome Tóxico, Minusválidos, Campañas sanitarias, y otros.

(2) Medicamentos en receta ordinaria sin visado, Medicamentos con visado (incluidas T.L.D), Medicamentos en receta T.L.D sin visado, Medicamentos con prescripción por principio activo, Medicamentos con prescripción por principio activo desabastecimiento, Efectos y accesorios sin visado, Efectos y accesorios con visado, Fórmulas magistrales y varios, Productos dietoterápicos y Otros grupos de recetas.

ANEXO III
FACTURA RESUMEN POR GRUPO DE FACTURACIÓN Y TIPO DE RECETA

FACTURA DE:
Régimen (1)
Grupo de facturación y Tipo de receta (2)

Mes: **Año**:

Farmacia número	Número de recetas	Total a P.V.P.	Aportación trabajador	Líquido a pagar
1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **..** **..** **Totales**				

---

(1) Trabajadores activos, Pensionistas, Accidentes de trabajo, Síndrome Tóxico, Minusválidos, Campañas sanitarias, y otros.

(2) Medicamentos en receta ordinaria sin visado, Medicamentos con visado (incluidas T.L.D), Medicamentos en receta T.L.D sin visado, Medicamentos con prescripción por principio activo, Medicamentos con prescripción por principio activo desabastecimiento, Efectos y accesorios sin visado, Efectos y accesorios con visado, Fórmulas magistrales y varios, Productos dietoterápicos y Otros grupos de recetas.

ANEXO IV
FACTURA RESUMEN GENERAL

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria
Mes: **Año:**

DISPENSACIÓN Y GRUPOS	Nº RECETAS	PRECIO FACT.	APORT. ACT.	LIQUIDO FACT.
MEDICAMENTOS SIN VISADO Activos receta ordinaria Pensionistas receta ordinaria Activos receta T.L.D Pensionistas receta T.L.D				
Sumas				
MEDICAMENTOS CON VISADO ORD.Y T.L.D Activos Pensionistas				
Sumas				
MEDICAMENTOS PRESCRIPCIÓN DOE Activos con y sin visado Pensionistas con y sin visado				
Sumas				
TOTAL MEDICAMENTOS:				
EFECTOS Y ACCESORIOS SIN VISADO Activos Pensionistas				
Sumas				
EFECTOS Y ACCESORIOS CON VISADO Activos Pensionistas				
Sumas				
TOTAL EFECTOS Y ACCESORIOS:				
FÓRMULAS MAGISTRALES Y VARIOS Activos Pensionistas				
TOTAL FORMULAS:				
PRODUCTOS DIETOTERÁPICOS Activos Pensionistas				
TOTAL PROD. DIETOTERÁPICOS:				
OTROS GRUPOS: Accidentes de trabajo Síndrome tóxico Asistencia sanitaria Ley 1/96 Minusválidos Campañas Sanitarias				
TOTAL OTROS GRUPOS:				
TOTAL GENERAL:				
TOTAL DEDUCCIONES:				
Descuento según la normativa vigente en materia de márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano				
Descuento A.I.O. 13%				
TOTAL DEDUCCIONES:				

GASTO FINAL:	

ANEXO V
DIFERENCIAS HALLADAS EN LA COMPROBACIÓN POR OFICINA DE FARMACIA

Farmacia número: **Mes /Año:**

Datos de localización de la receta					Clave causa diferencia	Importes facturados		Importes comprobados		Importe diferencia	
Grupo	Tipo receta	Régimen	Nº paquete	Nº receta		Precio facturación	Apor-tación	Precio facturación	Apor-tación	A favor SCS	A favor COF
Subtotal											
Subtotal											
Totales											

Grupos
1. Medicamentos
2. Efectos
3. Fórmulas

Tipos de receta
1. Ordinaria sin visado
2. Ordinaria con visado
3. T.L.D
4. Prescripción DOE
5. Prescripción DOE desabastecimiento
6. Dietoterápicos

Regímenes
1. Activos
2. Pensionistas
3. Accidentes
4. Síndrome Tóxico
5. Minusválidos
6. Campañas Sanitarias
7. Otros

ANEXO VI
RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS DE LA FACTURACIÓN

Mes / Año:
Grupo: **Tipo de receta:** **Regímenes:**

Nº de farmacia	Importes facturados		Importes comprobados		Importe líquido diferencia	
	Precio facturación	Aportación	Precio facturación	Aportación	A favor S.C.S.	A favor C.O.F.
Total:						

JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

Conceptos	**P.V.P.**	**Aportación**	**Líquido**
Facturado			
Comprobado			
DIFERENCIAS			

DILIGENCIA:

El importe líquido de las diferencias observadas en la comprobación de la facturación del mes asciende a euros a favor del

Santander, a

Jefe de la Unidad de Farmacia Por el C.O.F. de Cantabria:

Grupos
1. Medicamentos
2. Efectos
3. Fórmulas

Tipos de receta
1. Ordinaria sin visado
2. Ordinaria con visado
3. T.L.D
4. Prescripción DOE
5. Prescripción DOE desabastecimiento
6. Dietoterápicos

Regímenes
1. Activos
2. Pensionistas
3. Accidentes
4. Síndrome Tóxico
5. Minusválidos
6. Campañas Sanitarias
7. Otros

ANEXO VII
DIFERENCIAS QUE SE SOMETEN A CRITERIO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Mes / Año:

Datos de localización de la receta						Clave causa diferencia	Importe diferencia		Objeciones COF	Criterio de la Comisión
Grupo	Reg.	Tipo	Nº farmacia	Nº paq.	Nº receta		A favor S.C.S.	A favor C.O.F.		

Grupos
1. Medicamentos
2. Efectos
3. Fórmulas

Tipos de receta
1. Ordinaria sin visado
2. Ordinaria con visado
3. T.L.D
4. Prescripción DOE
5. Prescripción DOE desabastecimiento
6. Dietoterápicos

Regímenes
1. Activos
2. Pensionistas
3. Accidentes
4. Síndrome Tóxico
5. Minusválidos
6. Campañas Sanitarias
7. Otros

Santander, a

Jefe de la Unidad de Farmacia

Por el C.O.F. de Cantabria:

ANEXO VIII
ACTA DE RECEPCIÓN DE RECETAS

Facturación del mes de:

Número de cajas recibidas:

NUMERO DE CAJAS	GRANDES	PEQUEÑAS
Medicamentos sin visado en receta ordinaria		
Medicamentos sin visado en receta T.L.D		
Medicamentos con visado		
Medicamentos con prescripción por principio activo		
Medicamentos con prescripción por principio activo desabastecimiento		
Efectos y accesorios sin visado		
Absorbentes de incontinencia de orina		
Fórmulas –etiqueta autoadhesiva o sello		
Dietoterápicos		
Otros: accidentes, síndrome tóxico, minusválidos, campañas		

Número de cajas revisadas:

Resultado de la revisión:

....., a ..... de ..... de .....

El Jefe de la Unidad de Farmacia

Por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria

ANEXO IX

Claves	CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS
ERRORES DE FACTURACIÓN	
E.1	Recetas recibidas y no facturadas.
E.2	Recetas facturadas y no recibidas.
E.3	No deducida la aportación del asegurado o deducida indebidamente
ANULACIÓN TOTAL	
A.1	Sin cupón-precinto o sin justificante de la dispensación.
A.2	Cupón-precinto o justificante de la dispensación no coincidente con la prescripción. En el caso de precintos, la anulación afectaría a los precintos o comprobantes no coincidentes.
A.3	Recetas que precisando visado de la inspección no lo lleven en las condiciones establecidas.
A.4	Recetas con ausencia de datos de consignación obligatoria por el médico prescriptor.
A.5	Recetas con añadidos, enmiendas o tachaduras en el producto prescrito no salvadas por nueva firma del médico prescriptor según el punto .4.2.1.5 del Anexo B
A.6	Recetas en las que se acredite documentalmente su falsedad.
A.7	Recetas en las que se prescriban fórmulas magistrales que no se ajusten a lo establecido en el Anexo B
A.8	Recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, siendo la Entidad Aseguradora distinta de la Seguridad Social y recetas de beneficiarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU
A.9	Recetas dispensadas de algún producto de los excluidos de la prestación conforme al punto 2.4 del Anexo A.
A.10	Recetas con ausencia de la fecha de dispensación y/o fecha de dispensación anterior a la fecha de prescripción y/o visada
A.11	Otras causas de devolución acordadas por la Comisión de Seguimiento.
ANULACIÓN DEL MARGEN	
M.1	Recetas dispensadas después de los plazos de validez fijados al respecto.
M.2	Recetas facturadas después de noventa días de su dispensación.
M.3	Recetas en que figure cuantificado duración del tratamiento superior a tres meses o no figura cuantificado y no esta diligenciado por el farmacéutico
M.4	Ausencia de diligencia en las excepciones a datos de prescripción del punto 2.9.1 del Anexo A.
M.5	Ausencia de diligencia del farmacéutico en recetas en que no figure fecha de prescripción ni de visado tras consulta con Inspección Médica.
M.6	Ausencia de diligencia del farmacéutico en las recetas en las que se haya hecho una sustitución, de acuerdo con el Art. 86 de la Ley 29/2006 de garantías u uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
M.7	Ausencia de alguno de los datos de consignación obligatoria relativos al paciente, según lo recogido en el punto 2.9.3.del Anexo A
M.8	Ausencia de la fecha de prescripción sin diligenciar
M.9	Fecha de dispensación posterior al cierre de facturación.
M.10	Dispensación de envase de menor tamaño o menor número de envases al prescrito sin diligencia
M.11	Recetas T.L.D en los que se prescriba un producto no dispensable en este tipo de receta
M.12	Recetas prescritas por principio activo en que se demuestre falsedad en su desabastecimiento o en su tipo de facturación
M.13	Otras causas de devolución tratadas por Comisión de Seguimiento
ANULACIÓN PARCIAL	
P.1	Dispensados tamaños mayores o mayor número de envases que los prescritos.
P.2	Recetas de fórmulas magistrales en las que la cantidad de los productos dispensada exceda de la máxima autorizada.
P.3	Recetas en las que se dispense un número mayor de envases de los autorizados.
P.4	Recetas facturadas a precio diferente al establecido en Nomenclátor o acordado en este Concierto.
P.5	Recetas prescritas por principio activo y facturadas fuera de su tipo de dispensación.
RECETAS SUBSANABLES	
S.1	Ausencia de firma del farmacéutico y/o datos de identificación de la Oficina de Farmacia.
S.2	Añadidos, enmiendas o tachaduras en los datos de identificación de la farmacia y fecha de dispensación, no salvados por la diligencia del farmacéutico.
S.3	Ausencia de los datos de valoración en recetas de Formulas Magistrales, según lo recogido en el Anexo C.
S.4	Recetas de vacunas individualizadas que no lleven al dorso la composición cuali y/o cuantitativa.

ANEXO D.
Prestaciones con condiciones y procedimientos particulares

El presente Anexo regula las condiciones de dispensación y facturación con cargo al Servicio Cántabro de Salud de recetas prescritas por principio activo, tratamientos dietoterápicos complejos y nutrición enteral domiciliaria, y de absorbentes de incontinencia de orina.

A. PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO

1. PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN

1.1. Cuando la prescripción se realice por principio activo bajo la denominación oficial española (D.O.E.) o denominación común internacional (D.C.I.) sin especificar ninguna marca comercial concreta, el farmacéutico dispensará uno de los medicamentos existentes en el mercado que cumpla estrictamente las características de la prescripción (igual composición, dosis, forma farmacéutica, vía de administración y número de unidades) que tenga menor precio según el criterio recogido en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en el Acuerdo de Principio Activo descrito en el presente anexo.

1.2. En el acto de dispensación derivado de este tipo de prescripciones por principio activo, especialmente en los tratamientos crónicos, el farmacéutico procurará dispensar el mismo producto que venga utilizando el paciente, siempre que se cumplan las condiciones del punto anterior. Si no es posible, se informará del cambio realizado al paciente.

2. CONDICIONES ECONÓMICAS

2.1. Los precios menores correspondientes a las distintas presentaciones de medicamentos son los que se recogen en el Anexo 5 de la Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia, y en sus correspondientes actualizaciones.

2.2. En aquellos casos en que la presentación del medicamento no quede reflejada en el Anexo 5 citado en el punto anterior, el Servicio Cántabro de Salud fijará el precio menor en función de los medicamentos existentes con dicha presentación en el Nomenclator Oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo.

2.3. El Servicio Cántabro de Salud elaborará un *Vademécum de Principios Activos* donde figurarán todos los medicamentos con su precio de facturación para cada uno denominado *Precio Menor Operativo* (P.M.O.)

2.4. La dispensación de recetas prescritas por principio activo quedará como sigue:

PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO EN RECETAS DEL SCS

Prescripción	Dispensación	Precio de Facturación	Grupo de Facturación	Aportación Usuario
Principio Activo	MEDICAMENTO < PMO	PVP MEDICAMENTO	Principio activo	Según PVP
	MEDICAMENTO = PMO	PMO	Principio activo	Según PMO
	MEDICAMENTO > PMO	PMO	Principio activo	Según PMO
	MEDICAMENTO > PMO POR DESABASTECIMIENTO * justificar desabastecimiento	PVP MEDICAMENTO	Principio activo desabastecimiento	Según PVP

2.4.1. Cuando **el precio del medicamento dispensado por el farmacéutico sea inferior al Precio Menor Operativo**, el Servicio Cántabro de Salud abonará el PVPiva del medicamento.

2.4.2. Cuando **el precio del medicamento dispensado por el farmacéutico sea igual o superior al Precio Menor Operativo**, el Servicio Cántabro de Salud abonará el Precio Menor Operativo.

2.4.3. Cuando **exista desabastecimiento**, es decir, la no-existencia en el mercado de otro medicamento que se ajuste al principio activo prescrito por no estar comercializado o existir falta documentada del mismo por parte del almacén, se dispensará cualquier otro medicamento que, cumpliendo la prescripción, su precio se aproxime al Precio Menor Operativo.

El Servicio Cántabro de Salud abonará la cantidad correspondiente al PVPiva del medicamento dispensado.

Las recetas se facturarán en un grupo aparte: PRINCIPIO ACTIVO / DESABASTECIMIENTO.

La situación de desabastecimiento deberá justificarse mediante diligencia del farmacéutico, anotando la fecha y el número de albarán del centro o centros distribuidores, con el fin de certificar tal desabastecimiento.

3. PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN

3.1. Todas aquellas recetas prescritas por principio activo deberán ser presentadas en una/s caja/s identificada/s con la leyenda “POR PRINCIPIO ACTIVO”, independientemente de que estén o no visadas. Dentro de la caja deberán estar separadas en activos y pensionistas.

3.2. Los casos de desabastecimiento previstos en el punto 2.4.3 se deberán presentar en una/s caja/s con la leyenda “POR PRINCIPIO ACTIVO DESABASTECIMIENTO”.

3.3. La toma de datos, grabación y facturación realizada identificará a las recetas prescritas por principio activo y procederá a su facturación con el Vademécum de Principios Activos.

3.4. Si existiera alguna receta prescrita por principio activo que no figure en el Vademécum de Principio Activo, será facturada como si se tratará de una prescripción por nombre comercial, es decir, según el PVPiva del medicamento.

4. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM DE PRINCIPIOS ACTIVOS

La actualización de los Precios Menores Operativos de los medicamentos recogidos en el Anexo V será efectuada cuando se produzca una actualización de dicho anexo. Con periodicidad trimestral o a petición de cualquiera de las partes en caso de producirse un incremento-disminución del PVPiva de los medicamentos, el Servicio Cántabro de Salud puede actualizar los restantes Precios Menores Operativos. Dicha actualización entrará en vigor en la primera facturación completa del mes siguiente a su comunicación siempre y cuando se remita con anterioridad al día 20 del mes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y con carácter mensual, el Servicio Cántabro de Salud podrá proceder a la inclusión en el Vademécum de Principios Activos de los medicamentos dados de alta en el Nomenclator Oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dicha actualización se remitirá al Colegio Oficial de Farmacéuticos antes del día 20 del mes de facturación.

B. PRODUCTOS DIETOTERÁPICOS COMPLEJOS Y NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA

Los productos dietoterápicos complejos y de nutrición enteral domiciliaria no están incluidos en la normativa vigente como prestación farmacéutica, considerándose a efectos legales dentro de las prestaciones complementarias, por lo que sus contenidos respectivos se adecuarán a sus normativas específicas.

En tanto no se produzca una regulación específica en el ámbito sanitario público de Cantabria de los productos dietoterápicos complejos y nutrición enteral domiciliaria, la dispensación de estos productos se realizará, a través de oficina de farmacia, en receta oficial y contando con visado de Inspección previo a la dispensación, tratándose de productos que carecen de aportación.

1. PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN

1.1. Sólo serán dispensables con cargo al Servicio Cántabro de Salud las prescripciones de productos dietorerápicos complejos y nutrición enteral domiciliaria que, formando parte de las prestaciones complementarias del Sistema Nacional de Salud, se efectúen en receta oficial y lleven la correspondiente autorización sanitaria mediante visado de Inspección. Dichos productos quedan reflejados en el "Listado de productos dietéticos inscritos en el registro de alimentos para usos médicos especiales y susceptibles de financiación", siempre y cuando los pacientes reúnan las condiciones establecidas en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y Procedimiento para su actualización.

1.2. En cada receta podrá prescribirse hasta cuatro envases del mismo producto, siempre y cuando no se supere la cantidad necesaria para cubrir un mes de tratamiento. El beneficiario no abonará ninguna aportación por la dispensación de estos productos como queda reflejado en la leyenda "Producto Dietoterápico exento de aportación. Nutrición Enteral sin aportación"

2. CONDICIONES ECONÓMICAS

2.1. La Gerencia del Servicio Cántabro de Salud abonará a las oficinas de farmacia por la dispensación de estos productos, como Precio Máximo Financiado (P.M.F.), la cuantía que figura en el "Listado-Nomenclator de Dietas", incorporado a este Anexo como Tabla V.

2.2. La Gerencia del Servicio Cántabro de Salud actualizará periódicamente el citado "Listado-Nomenclator de dietas" atendiendo a las variaciones (altas o bajas) que se produzcan en el Registro de alimentos para usos médicos especiales susceptibles de financiación por el Sistema Nacional de Salud. Las variaciones en las condiciones económicas de la oferta serán tratadas en la Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica.

2.3. Las variaciones de los P.M.F. debidas a variaciones de los precios de venta de laboratorio (P.V.L.) de los productos incluidos en el "Listado-Nomenclátor de dietas" serán actualizadas, con periodicidad semestral, por el Grupo Técnico de trabajo constituido según lo establecido en el punto 4 , aplicando los porcentajes al efecto fijados.

3. PRECIO MÁXIMO FINANCIADO PARA LA NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA Y LOS TRATAMIENTOS DIETOTERÁPICOS COMPLEJOS.

La cuantía que se establece como Precio Máximo Financiado para cada producto de nutrición enteral domiciliaria y de tratamientos dietoterápicos complejos, se determina tomando como base la suma de los siguientes conceptos:

- El valor medio del precio de venta de laboratorio (P.V.L.)
- El porcentaje sobre el precio de venta de almacén (P.V.A.) en calidad de margen de distribución, que corresponde al fijado para especialidades
- El porcentaje sobre precio de venta al público (P.V.P.), en concepto de margen profesional, que será, al menos, el que se utiliza para envases clínicos.
- El IVA correspondiente

4. GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO.

La Comisión de Seguimiento de la Prestación Farmacéutica constituirá con representantes de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria un grupo técnico de trabajo para la elaboración de estudios y propuestas que, una vez elevadas a la Comisión de Seguimiento serán aprobadas, si procede, sobre los cambios que puedan afectar a esta prestación.

La mecanización, prevista en el Anexo C, se hará mediante la lectura de la información del producto de prestación dietética contenida en el código identificativo (6 dígitos numéricos), facilitando así un conocimiento pormenorizado del consumo en la

Comunidad y proporcionando al grupo técnico de trabajo la información necesaria par las actuaciones que se estimen oportunas.

5. FACTURACIÓN.

La facturación de estos productos se realizará tal como se recoge en el Anexo C de este Concierto y de acuerdo con el código identificativo y precio de facturación que para cada producto figura en el "Listado-Nomenclátor de dietas" que figura en este anexo.

Únicamente podrán facturarse aquellos productos que lleven cupón precinto normalizado, adjuntándose éste como comprobante de la dispensación.

C. ABSORBENTES DE INCONTINENCIA DE ORINA

1. PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN

Sólo serán dispensables con cargo al Servicio Cántabro de Salud las prescripciones de Absorbentes de Incontinencia de Orina que se encuentren incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud, se efectúen en receta médica oficial y lleven la correspondiente autorización sanitaria mediante visado de Inspección en las condiciones establecidas en el Anexo A de Condiciones de Dispensación.

En la prescripción se deberá consignar el nombre comercial o genérico (A.I.O.), el modelo del absorbente (RECTANGULAR, ELÁSTICO O ANATÓMICO), el tipo de absorción del pañal (DIA, NOCHE O SUPERNOCHE), la talla (PEQUEÑA, MEDIANA O GRANDE), así como el número de unidades.

La talla hace referencia al contorno en centímetros de cintura y su ausencia implicará la dispensación adecuada a las necesidades del paciente.

El tamaño hace referencia al número de unidades.

La receta podrá ser dispensada con la ausencia de la absorción del pañal, siempre que éste quede perfectamente identificado y sea el único posible para dispensar. Si no es el caso y, en ausencia de absorción del pañal, siempre se diligenciará el tipo de absorción por el farmacéutico, previa consulta a los Servicios de Inspección.

El dispensar una absorción diferente de la prescrita, tanto mayor como menor, supondrá la anulación total del importe del producto, a no ser que esté debidamente justificada por el farmacéutico dicha dispensación, con diligencia al dorso, previa consulta a los Servicios de Inspección.

2. CONDICIONES ECONÓMICAS

En materia de Absorbentes de Incontinencia de Orina se aplicará en la facturación de estas dispensaciones una deducción del 13% sobre el PVP.-IVA de los absorbentes de incontinencia de orina, según lo acordado entre el Servicio Cántabro de Salud y las Oficinas de Farmacia referido a las condiciones económicas de la facturación de los Absorbentes de Incontinencia de Orina.

3. FACTURACIÓN

La facturación de estos productos sanitarios se realizará tal como se recoge en el Anexo C de este Concierto y de acuerdo con el precio de facturación que para cada producto figura en el Nomenclátor Oficial de Productos Farmacéuticos.

TABLA V. LISTADO NOMENCLATOR DE DIETAS

Ver el Listado vigente actualmente.

www.cofcantabria.org /Acceso colegiados /Listados

En caso de no tener acceso a Internet, solicitar en el Colegio.